

De kunde van het huis.

Visienota over wat competentiecentra zijn, waartoe zij bestaan en welke ruimte zij nodig hebben

—
versie 01 september 2026, Tom Braes
—

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Proloog. De spanning die iedereen herkent.....	4
Hoe deze nota te gebruiken.....	4
Kernbeslissing. Wat een competentiecentrum is	5
FUNDAMENT	6
1 Wat een competentiecentrum is	7
1.1 De vijf werkwoorden.....	7
1.2 De vier kenmerken	7
1.3 Waarom één domein, en toch interprofessioneel	9
1.4 Verhouding tot de bestaande omschrijving.....	9
2 Waartoe competentiecentra bestaan	11
2.1 Het argument in drie stappen	11
2.2 Middelen en bestaansredenen	12
2.3 Georganiseerde vreemdheid als tweede bestaansredenen.....	12
3 Paden en gewoonten: waarom grenzen ontstaan.....	14
3.1 Hoe vakmanschap zijn eigen grenzen produceert.....	14
3.2 Het pad en de tractor	15
3.3 Reflectie in twee ordes.....	15
3.4 Professionele tolerantie.....	16
3.5 Productieve disharmonie.....	17
DIAGNOSE.....	18
4 Diagnose: spanning als ontwerpvrage.....	19
4.1. De matrix als ontwerpkeuze	19
4.2. Exploitatie en exploratie: spanning als systeemkenmerk.....	19
4.3. Wanneer spanning naar mensen verschuift	20
4.4. Vier breuklijnen in één systeem.....	20
4.5 Werkbare asymmetrie	21

4.6	Vier instrumenten, vier doorsneden.....	21
5	Ons ziekenhuis: traditie, transitie en professionele autonomie.....	23
5.1	Waar gezag vandaan komt	23
5.2	Een organisatie tussen traditie én transitie	23
5.3	Universitair karakter en hoog-autonome professionals.....	24
5.4	Waar deze vormen elders voorkomen.....	24
5.5	Onze eigen voorgeschiedenis	24
	ONTWERP	27
6	Lidmaatschap: wie de opdracht draagt	28
6.1	Lidmaatschap als expliciete rol	28
6.2	Lidmaatschap als dubbele verankering	28
6.3	Een gelaagd model van lidmaatschap.....	29
6.4	Wat de dialoog beslecht.....	29
7	Maturiteit: vier dimensies.....	31
7.1	Waarom een maturiteitslens.....	31
7.2	Het model in één beeld	31
7.3	Besluitvormingscapaciteit: van relationele invloed naar structureel mandaat	32
7.4.	Capaciteitstoewijzing: van individuele loyaliteit naar collectief beheer	33
7.5.	Professionele autoriteit: van persoon naar instituut	33
7.6.	Governance en verantwoording: van vrijblijvend overleg naar lerend systeem.....	34
7.7.	Samenhang tussen de dimensies	35
7.8.	Innovatie als gevolg van ontwerp	35
8	Ontwerpprincipes en governance-architectuur	37
8.1	Waarom governance professionele ruimte creëert.....	37
8.2	Drie ontwerpprincipes	37
8.3	Zeven kerncomponenten	38
8.4	Samenhang	39
	TOEPASSING EN HERIJKING	41
9	Ambitie per centrum	42
9.1	Niet elk domein vraagt dezelfde ambitie.....	42
9.2	Het gesprek dat het model mogelijk maakt.....	43
9.3	Wat dit van de directie vraagt.....	43
10	Praktijkgemeenschap: wat er tussen professionals gebeurt.....	45
10.1	Een tweede ontwerpbril: van structuur naar praktijk	45
10.2	De 'families' en praktijken van een florerende kennissamenleving.....	45
10.3	Wat de drie families ons zeggen	46
10.4	Verhouding tot het maturiteitsmodel.....	47
11	De toets: van praktijk terug naar bestaansredenen	48

11.1	Twee lussen in één systeem	48
11.2	Drie toetsen op drie niveaus.....	49
11.3	De herijkingsclausule	49
Slot. Wat deze nota vraagt		50
Bijlage 1: het denkteam achter deze nota		51
Bijlage 2. Wat het huis zich verbindt te doen		54

Proloog. De spanning die iedereen herkent

Kwart voor negen, donderdagochtend. De coördinator van een competentiecentrum wacht op vier mensen. Twee komen niet: op hun afdeling liep een opname uit die niet kon wachten. Het overleg gaat door met de helft, het dossier schuift een maand op, en niemand heeft hier iets verkeerd gedaan.

Competentiecentra en kernteams delen dezelfde mensen, dezelfde uren en dezelfde aandacht. Waar klinische expertise en operationele continuïteit elkaar raken, ontstaat spanning: over prioriteiten, over beslissingsruimte en over wat er gebeurt wanneer beide partijen gelijk hebben.

Elke afdeling kent het, elk centrum kent het. We lezen het soms als een samenwerkingsprobleem, als gebrek aan afstemming of als onvoldoende engagement.

Deze nota leest het als ontwerpogave. Twee legitieme opdrachten vragen dezelfde mensen en dezelfde uren. Waar ze elkaar raken, hoort het te schuren.

Dat is meteen een geruststellende lezing. **Een samenwerkingsprobleem vraagt betere mensen. Een ontwerpprobleem vraagt een beter ontwerp. En een ontwerp kunnen we samen maken en bijschaven.**

Hoe deze nota te gebruiken

Deze nota bepaalt waartoe competentiecentra bestaan en welke ontwerpkeuzes daaruit volgen. U kunt haar op twee manieren lezen: van voor naar achter, als een redenering die stap voor stap wordt opgebouwd, of per deel, als naslagwerk rond één ontwerpvraag.

Negen denkkaders werpen elk een ander licht op dezelfde werkelijkheid. Samen behandelen zij vragen over structuur, samenwerking, spanning, mandaat, professionele identiteit en leren. Hun portretten staan in bijlage 1.

Eén tabel keert in deze nota tweemaal terug, vooraan en achteraan, met dezelfde rijen. Zij houdt bij wie waarover beslist.

Wat	Wie beslist
De finaliteit en de definitie van een competentiecentrum	Deze nota
De verhouding tussen de verticale en de horizontale as: adviseren of sturen	Het directiecomité
Lidmaatschap, samenstelling en afbakening per centrum	De dialoog met de competentiecentra

Die driedeling is bewust. **De finaliteit volgt uit de opdracht. Het mandaat volgt uit de organisatie. De invulling volgt uit de praktijk.** Alleen wanneer die drie op elkaar aansluiten, kan een competentiecentrum zijn opdracht waarmaken.

Kernbeslissing. Wat een competentiecentrum is

Deze nota maakt één definitie richtinggevend voor het hele huis. Zij staat vooraan omdat elke latere afspraak over mandaat, capaciteit en governance ervan afgeleid wordt. Deel 2 verantwoordt haar, deel 3 verklaart waarom een organisatie die verantwoording actief moet organiseren.

De definitie

Een competentiecentrum is het collectief dat, dwars over de diensten heen, de expertise van één professioneel domein ontwikkelt, borgt, doorgeeft en herziet, die expertise afstemt met andere professionele domeinen, en binnen en buiten het huis aanspreekbaar is op wat in dat domein als goede praktijk geldt.

Wat deze beslissing vervangt

Het ziekenhuis hanteert vanaf nu deze ene definitie. De omschrijving op het intranet vertrekt vanuit een bemanningslogica en wordt buiten gebruik gesteld. De bemanningsopdracht die zij bij de coördinator legde, krijgt een expliciete plaats elders in de organisatie; 1.4 benoemt die plaats.

Wat deze beslissing openlaat

De definitie bepaalt de aard en de finaliteit van een competentiecentrum. Zij laat vier vragen open: wie lid is, hoe 'hard' het mandaat is, hoeveel centra het huis telt, en welk taalregister we voor lidmaatschap kiezen. De beslistafel hierboven maakt zichtbaar wie daarover beslist.

BEWEGING I · DELEN 1 TOT 3

FUNDAMENT

Wat een competentiecentrum is, waartoe het bestaat, en waarom professionele domeinen zich vanzelf afsluiten. Deze drie delen leggen de basis: zij bepalen waarop alle ontwerpkeuzes verderop steunen: de definitie, de dubbele bestaansreden, en het mechanisme waarlangs gewoonten vanzelfsprekend worden.

1 WAT EEN COMPETENTIECENTRUM IS

In één zin. Competentiecentra zijn de manier waarop dit huis ervoor zorgt dat expertise van het huis is, van het huis blijft, en buiten het huis als goede praktijk herkenbaar wordt.

Waarom dit ertoe doet. De omschrijving op ons intranet beschrijft een **bemanningslogica**. Wat wij vandaag van competentiecentra verwachten, veronderstelt een **kennislogica**. Zolang beide naast elkaar bestaan, rust elke afspraak over mandaat, capaciteit en governance op een onduidelijke grondslag.

Tegelijk is de opdracht zwaarder geworden. Loopbanen worden korter en mobieler. Taakverschuiving en nieuwe functies vragen dat bekwaamheid expliciet wordt beschreven in plaats van stilzwijgend verondersteld op basis van een diploma. Specialisatie verdiept, terwijl teams breder en multidisciplinair worden samengesteld. Expertise verlaat het huis soms sneller dan ze zich opbouwt. Borging en overdracht zijn daarmee een expliciete organisatieopdracht geworden.

Wat hieruit volgt. Het ziekenhuis hanteert vanaf nu één definitie van een competentiecentrum en belegt de bemanningsopdracht uitdrukkelijk elders.

1.1 De vijf werkwoorden

Vijf werkwoorden dragen deze definitie. Samen beschrijven ze de volledige levenscyclus van expertise.

ONTWIKKELT. Het centrum past goede praktijk toe en schept tegelijk de voorwaarden waarin nieuwe kennis, praktijken en standaarden ontstaan. Deel 7 laat zien waarom dat vermogen volgt uit ontwerp.

BORGT. Expertise verhuist van persoon naar instituut. Kennis die uitsluitend in hoofden, gewoonten en persoonlijke mappen leeft, vertrekt met wie haar draagt. Borging maakt haar vindbaar, bruikbaar en overdraagbaar. Zo wordt expertise minder afhankelijk van individuele personen.

GEEFT DOOR. Kennis wordt aangeleerd, gedeeld en hergebruikt. Deze opdracht weegt vandaag het zwaarst en geeft de centra hun naam.

HERZIET. Goede praktijk is nooit definitief. Het centrum bewaakt wat werkt en onderzoekt wat aangepast of stopgezet moet worden. De delen 3 en 11 leveren daarvoor het mechanisme.

STEMT AF. Geen enkel domein staat op zichzelf. Het centrum verbindt zijn expertise met die van aanpalende domeinen, zodat verschillen zichtbaar worden vóór ze voor patiënten problemen worden.

1.2 De vier kenmerken

Zij bepalen waarover we spreken, wie de expertise draagt, waartoe ze verplicht en naar wie ze zich richt.

DOMEIN. Elk competentiecentrum kiest één afgebakend professioneel domein. Die afbakening is de eerste ontwerpdaad: zij bepaalt wie er thuishoort, waarover het centrum met gezag kan spreken, en waar zijn verantwoordelijkheid overgaat naar een ander centrum.

Een domein vertoont daarom voldoende samenhang om collectieve expertise te kunnen opbouwen, en is scherp genoeg begrensd om aanspreekbaarheid mogelijk te maken. *Een centrum dat overal over gaat, kan nergens werkelijk op worden aangesproken.*

COLLECTIEF. De expertise berust bij het verband en blijft beschikbaar voor het huis bij functiewissel, langdurige afwezigheid of vertrek.

Documentatie, hergebruik en overdracht zijn daarmee kenmerken van volwassenheid. Een volwassen competentiecentrum kan tonen hoe kennis wordt vastgelegd, waar collega's haar vinden en hoe nieuwe medewerkers haar leren toepassen. Daarbij hoort een ongemakkelijke vraag: *welke expertise verlaat vandaag het huis wanneer één persoon vertrekt, en wat organiseren we nu al om dat op te vangen?*

AANSPEEKBAARHEID. Het centrum staat voor wat in zijn domein als goede praktijk geldt en legt daar verantwoording over af. Het maakt zichtbaar welke standaarden het hanteert, waarop die steunen en hoe ze worden onderhouden.

Aanspreekbaarheid is het scharnier tussen expertise en mandaat. Wie aanspreekbaar is op een resultaat, heeft invloed nodig op de voorwaarden waaronder dat resultaat tot stand komt. Verantwoordelijkheid zonder beslissingsruimte laat een centrum afhankelijk van informele bereidheid en persoonlijke goodwill.

De precieze beslissingsruimte ligt met deze definitie nog niet vast. Wel legt zij een ontwerpvoorwaarde vast: *wie formeel aanspreekbaar wordt gemaakt, krijgt een mandaat dat daarmee in verhouding staat.*

CURATORSCHAP. Omdat het centrum rond een afgebakend domein werkt, expertise collectief draagt en daarop aanspreekbaar is, vervult het een curatorrol voor dat vakgebied. Het selecteert wat waarde heeft, houdt het in goede staat, maakt het toegankelijk, plaatst het in samenhang en toont het aan anderen.

Dat curatorschap werkt in twee richtingen.

- **Naar binnen** vinden collega's er wat zij nodig hebben om goede zorg te verlenen; nieuwe medewerkers leren er het vak zoals het in dit huis wordt uitgeoefend; ervaringen uit verschillende diensten komen samen, zodat lokale oplossingen gedeelde kennis worden.
- **Naar buiten** vertegenwoordigt het centrum het huis binnen zijn domein: het spiegelt de eigen praktijk aan wat elders gebeurt, onderhoudt professionele verbindingen en haalt binnen wat het huis nog mist. Geen enkel domein staat op zichzelf. Daarom onderhoudt een competentiecentrum niet alleen verbindingen naar buiten, maar ook naar aanpalende expertisevelden binnen het huis, waar verantwoordelijkheid, kennis en praktijk elkaar raken.

De metafoor verheldert ook een eigendomsvraag die anders blijft sluimeren. Een curator bezit de collectie niet; zij draagt er zorg voor namens de instelling. Zo is expertise van het huis, terwijl het competentiecentrum haar namens het huis beheert.

Ook hier hoort een ongemakkelijke vraag: *waar is dit competentiecentrum werkelijk een venster naar buiten, en waar is het vooral naar binnen gekeerd geraakt?*

1.3 Waarom één domein, en toch interprofessioneel

Wie deel 2 leest, kan zich afvragen waarom een competentiecentrum rond één domein wordt opgebouwd wanneer geen enkele discipline het hele verhaal vertelt.

De sleutel ligt in het onderscheid tussen domein en beroepsgroep. Een domein is een samenhangend geheel van expertise waarover het huis aanspreekbaar wil zijn. Sommige domeinen vallen samen met één beroepsgroep; andere verbinden meerdere disciplines rond dezelfde expertise. Bovendien raken veel domeinen aan andere domeinen. **Interprofessioneel werken speelt zich daarom niet alleen af binnen een competentiecentrum, maar ook tussen competentiecentra.**

De intranetomschrijving koppelde lidmaatschap aan de functie; deze definitie koppelt het aan het domein.

Daarmee worden twee ontwerp vragen zichtbaar. De eerste is waarvoor een centrum aanspreekbaar is: die vraagt een duidelijke afbakening. De tweede is vanuit welke perspectieven het centrum naar dat domein kijkt: die vraagt een bredere tafel. **Elk domein heeft blinde vlekken die het zelf moeilijk ziet**, en deel 3 beschrijft het mechanisme waarlangs dat gebeurt.

Het curatorschap maakt dat onderscheid zichtbaar. **Eén onderwerp. Vele blikken. Aanspreekbaarheid vraagt grenzen. Kwaliteit vraagt perspectieven.**

Teken het domein dus scherp genoeg om aanspreekbaar te zijn, en organiseer voldoende perspectieven om het kritisch en alert te houden. Hoe breed dat domein loopt en wie er aan tafel hoort, beantwoordt de dialoog met elk centrum afzonderlijk; deel 6 levert het vocabularium.

1.4 Verhouding tot de bestaande omschrijving

De omschrijving die vandaag op het intranet staat, luidt:

"Een competentiecentrum is de ziekenhuisbrede verzameling van collega's die eenzelfde functie uitoefenen op verschillende diensten. Een competentiecentrumverantwoordelijke wordt coördinator genoemd. Hij of zij staat in voor rekrutering en begeleiding, de praktische organisatie en voor de concrete inschakeling van de medewerkers in de verschillende diensten en programma's."

Zij is intern coherent en beschrijft nauwkeurig één organisatiemodel: lidmaatschap volgt de functie, de coördinator organiseert bemanning en begeleiding, en de aansturing loopt via de medische lijn. In die ene omschrijving zitten

echter drie verschillende opdrachten vervat. Juist hun vermenging verklaart een belangrijk deel van de huidige onduidelijkheid.

	Bemanning	Competentie	Kennis
De vraag	Wie staat waar, en wanneer?	Wat moet iemand in dit domein kunnen, en hoe leert die persoon dat?	Wat geldt in dit domein als goede praktijk?
Wat het vraagt	Overzicht van bezetting, roosters, inzet en instroomvolume	Opleidingslijnen, begeleiding, inwerking en zicht op kritieke bekwaamheid	Standaarden, richtlijnen, toetsing, vernieuwing en vertegenwoordiging van het domein naar buiten
Waar het thuishoort	De lijn en kernteams, met HR	Het competentiecentrum	Het competentiecentrum

De bestaande omschrijving legt de nadruk op bemanning en begeleiding, maar spreekt zich nauwelijks uit over het beheer en de ontwikkeling van kennis als organisatieopdracht.

De definitie in deze nota maakt een andere keuze: competentieontwikkeling en kennisontwikkeling horen bij het competentiecentrum, de bemanningsopdracht hoort elders. Dat onderscheid heeft concrete gevolgen. Instroomplanning, roostering en de operationele inzet van medewerkers krijgen een plaats buiten het competentiecentrum. Opleiding, begeleiding, overdracht en het onderhouden van goede praktijk blijven nadrukkelijk binnen het centrum.

De scheiding is niet absoluut. De drie opdrachten beïnvloeden elkaar voortdurend: een opleidingsvraag raakt de inzetbaarheid, een tekort in de bezetting zet competentieontwikkeling onder druk, een nieuwe standaard vraagt bijkomende opleiding of een andere personeelsmix. Samenhang blijft dus noodzakelijk. Samenhang en één verantwoordelijkheid zijn verschillende dingen.

De keuze om competentieontwikkeling binnen het centrum te beleggen, is fundamenteel. Een competentiecentrum waarin competentieontwikkeling structureel elders ligt, draagt zijn naam ten onrechte.

De intranetomschrijving beschrijft een **functiegroep**. De ambitie veronderstelt een **kennisgemeenschap met mandaat**. De dagelijkse praktijk lijkt vaak op een **netwerk zonder vast lidmaatschap**. Die drie logica's lopen uiteen zonder dat er ooit expliciet tussen is gekozen. Een heldere definitie lost dat verschil niet op. Zij dwingt wel de vraag af welke logica het ziekenhuis werkelijk wil organiseren.

2 WAARTOE COMPETENTIECENTRA BESTAAN

***In één zin.** De werkelijkheid van elke patiënt is breder dan het domein van elke afzonderlijke discipline; samenwerking is daarmee een professionele opdracht.*

***Waarom dit ertoe doet.** Interprofessionele samenwerking wordt meestal verdedigd met praktische argumenten: zij maakt zorg efficiënter, aangenamer en voorkomt dubbel werk. Er bestaat een fundamenteel argument, en dat argument draagt deze hele nota. Het maakt van samenwerking een rechtstreeks gevolg van de bestaansredenen van zorgberoepen zelf. Tegelijk introduceert het een onderscheid dat in de rest van deze nota blijft terugkeren: dat tussen middelen en bestaansredenen.*

Wat hieruit volgt.** Het ziekenhuis organiseert en beschermt ruimte waarin professionele perspectieven elkaar ontmoeten, bevragen en verrijken. **Georganiseerde vreemdheid is een expliciete opdracht.

2.1 Het argument in drie stappen

DE PATIËNT. Elke patiënt brengt een werkelijkheid mee die de grenzen van één discipline overstijgt. Symptomen, herstelprocessen en crisissen worden gevormd door biologische, psychologische, sociale en contextuele factoren die zich vanuit één perspectief niet laten vatten.

DE DISCIPLINE. Daarom kan geen enkele discipline het volledige verhaal vertellen. Elke discipline ziet iets wezenlijks van de werkelijkheid en nooit haar geheel. **Zij kan de waarheid vertellen, en niets dan de waarheid, maar nooit de hele waarheid.**

Wat buiten het eigen perspectief ligt, blijft gedeeltelijk onzichtbaar. Daaruit volgt een professionele verantwoordelijkheid: epistemische bescheidenheid.

DE OPDRACHT. Alle zorgberoepen delen dezelfde opdracht: doen wat het beste is voor de patiënt. Samenwerking verruimt de kennis- en handelingsbasis van elke discipline aantoonbaar. **Daarmee wordt zij een professionele én ethische opdracht.**

Dat vraagt één precisering. Samenwerken reikt verder dan gelijktijdig rond dezelfde patiënt werken. Wanneer iedere discipline uitsluitend vanuit het eigen perspectief handelt, blijft iedereen even wetend en even onwetend als voordien. Van interprofessionele samenwerking is pas sprake wanneer inzichten uit andere disciplines het eigen denken en handelen mee vormgeven.

*Hierin ligt **de eerste bestaansreden** van een competentiecentrum. Het bestaat omdat de werkelijkheid van onze patiënten breder is dan het domein van welke discipline ook, en omdat geen enkele discipline op zichzelf over voldoende kennis beschikt om die werkelijkheid volledig te begrijpen.*

2.2 Middelen en bestaansreden

Als samenwerking zo fundamenteel is voor goede zorg, dringt zich een volgende vraag op: *hoe voorkomen we dat beroepsgroepen hun eigen werkwijzen gaan beschermen op een manier die samenwerking belemmert?*

Professionele praktijken krijgen vorm in taal, routines, procedures, overlegvormen en organisatieafspraken. Omdat die vertrouwd zijn, gaan ze vanzelfsprekend lijken. Het blijven instrumenten in dienst van een opdracht.

Middelen komen en gaan; de opdracht blijft. Een beroepsgroep bestaat om haar maatschappelijke en professionele opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Werkwijzen behouden hun waarde zolang zij aan die opdracht bijdragen. Veranderen de omstandigheden, dan veranderen de werkwijzen mee.

Wie vooral zijn werkwijzen verdedigt, verdedigt zijn middelen. Een competentiecentrum dat zijn opdracht verdedigt, kan zijn middelen herzien wanneer zij niet langer de beste resultaten opleveren.

Dat is niet vanzelfsprekend. Professionele socialisatie belooft stabiliteit, herkenbaarheid en continuïteit, en daardoor raken middelen geleidelijk verward met de opdracht waarvoor ze ooit ontwikkeld werden. Een competentiecentrum maakt die verwarring zichtbaar. De jaarlijkse toets uit deel 11 bouwt op precies die functie voort.

2.3 Georganiseerde vreemdheid als tweede bestaansreden

Daarmee wordt een tweede opdracht zichtbaar.

Het kritisch bevragen van professionele vanzelfsprekendheden vraagt tijd, veiligheid en soms ook moed. Die moed mag geen toegangsvoorwaarde zijn voor leren. De organisatie draagt daarom de verantwoordelijkheid om ruimte voor reflectie expliciet te organiseren, te beschermen en te normaliseren.

GEORGANISEERDE VREEMDHEID. Een competentiecentrum maakt georganiseerde vreemdheid mogelijk. Het is de plek waar perspectieven van buiten het eigen vakgebied binnenkomen, waar andere disciplines mee aan tafel zitten, en waar vragen gesteld mogen worden die binnen de eigen beroepsgroep ongewoon of ongemakkelijk klinken.

Daarin ligt de tweede bestaansreden. Het centrum creëert een omgeving waarin professionele vanzelfsprekendheden zichtbaar, bespreekbaar en veranderbaar worden. Wat vandaag evident lijkt, wordt daar opnieuw onderwerp van onderzoek. Wenger vat het samen: **een professionele gemeenschap ontleent haar waarde aan wat zij weet én aan welke vragen er gesteld mogen worden.**

Dat verklaart tegelijk waarom innovatie in deze nota verschijnt als een gevolg van ontwerp.

*Competentiecentra bestaan om twee redenen. Ze versterken de kwaliteit van zorg door kennis over disciplinaire grenzen heen te verbinden. En ze creëren een omgeving waarin professionele vanzelfsprekendheden onderzocht, bevraagd en vernieuwd kunnen worden. **Goede zorg vraagt beide.***

3 PADEN EN GEWOONTEN: WAAROM GRENZEN ONTSTAAN

In één zin. Professionele gewoonten slijten in tot vanzelfsprekendheden; wat vanzelfsprekend is, verdwijnt uit het gesprek.

Waarom dit ertoe doet. Iedere zorgprofessional weet dat samenwerking noodzakelijk is. Toch blijken de grenzen tussen disciplines opmerkelijk hardnekkig. Dat is een voorspelbaar gevolg van hoe vakmanschap wordt opgebouwd en doorgegeven. Professionele gemeenschappen leren hun leden wat zij moeten doen én hoe zij naar de werkelijkheid kijken. Sommige aannames worden daardoor zo vanzelfsprekend dat niemand ze nog opmerkt. Dit deel verklaart hoe zulke grenzen ontstaan en waarom reflectie niet spontaan ontstaat, maar ontworpen moet worden.

Wat hieruit volgt. Gemengde samenstelling, externe stemmen en wisselende contexten krijgen een vaste plaats in de agenda van elk competentiecentrum.

De redenering in dit deel volgt het werk van Steen Wackerhausen over samenwerking, professionele vorming en reflectie over grenzen heen. Zij is bewust niet moraliserend. **Grensbewaking is een normaal kenmerk van professionele gemeenschappen.** Professionele grenzen zijn geen defect dat moet worden weggewerkt. Zij zijn een normaal gevolg van vakmanschap. De vraag is niet hoe grenzen verdwijnen, maar hoe zij bespreekbaar blijven.

3.1 Hoe vakmanschap zijn eigen grenzen produceert

Professionele vorming werkt op twee niveaus. Beide zijn noodzakelijk. Beide produceren ook grenzen.

HET NIVEAU VAN DE BEROEPSGROEP. Op **macroniveau** ontwikkelt een beroepsgroep haar publieke gezicht: haar bevoegdheden, erkenning, status en maatschappelijke rol.

Dat gebeurt nooit geïsoleerd. Iedere discipline beweegt zich tussen andere disciplines, beleidskeuzes en technologische ontwikkelingen. In die wisselwerking ontstaan discussies over verantwoordelijkheden, expertise en invloed. Sommige activiteiten worden door meerdere beroepsgroepen geclaimd, andere gemakkelijk doorgeschoven. **Naburige disciplines delen dus een opdracht en concurreren tegelijk om ruimte, erkenning en gezag.**

HET NIVEAU VAN DE PROFESSIONAL. Op **microniveau** gaat het om wat iemand moet kennen, geloven en doen om als volwaardig lid van een beroepsgroep te gelden.

Dat omvat veel meer dan formele kennis: taal, routines, professionele intuïties, manieren van kijken, verklaren en waarderen. Het grootste deel daarvan wordt opgenomen in de dagelijkse praktijk, door observatie, nabootsing en sociale bevestiging. Na verloop van tijd gebeurt iets belangrijks. Gewoonten worden vanzelfsprekendheden. Wat ooit een keuze was, voelt als de natuurlijke manier van kijken. Wat vanzelfsprekend wordt, hoeft niet langer uitgelegd te worden, en wat niet meer uitgelegd hoeft te worden, verdwijnt uit het gesprek. **Zo ontstaan de hardnekkigste grenzen tussen disciplines: onzichtbaar voor wie erbinnen werkt.**

3.2 Het pad en de tractor

Wackerhausen beschrijft dit mechanisme met een beeld uit zijn jeugd. Op de boerderij waar hij opgroeide liepen de koeien elke dag dezelfde route door de weide, achter Maren aan, over sporen die zij in de loop der jaren zelf hadden uitgesleten. Zij volgden die sporen ook waar ze kronkelden en een rechte lijn korter was. De paden lagen er al voor de dieren die erop liepen.

Op een dag stond er een tractor dwars over zo'n pad. De kudde bleef staan, verward. Als Maren had kunnen nadenken, had ze nagedacht over de tractor.

Daarin schuilt het punt. Wij vergaderen over storingen, conflicten en knelpunten, en veel minder over de gewoonten die ons handelen dagelijks sturen. **Juist omdat het pad vanzelfsprekend is, blijft het buiten beeld.**

3.3 Reflectie in twee ordes

Als vanzelfsprekendheden onzichtbaar zijn, **hoe maak je ze dan opnieuw zichtbaar?**

Reflectie heeft vier bestanddelen. We denken ergens **over** na, **met** bepaalde begrippen, **vanuit** een bepaald perspectief en **binnen** een bepaalde context. Reflectie van de eerste orde houdt die vier constant. Reflectie van de tweede orde verandert er bewust minstens één.

Bestanddeel	Eerste orde	Tweede orde
Waarover?	De onderwerpen die het vak belangrijk vindt, meestal een obstakel of probleem.	Ook de vanzelfsprekendheden van het vak zelf: waarom doen we het zo?
Waarmee?	De begrippen van het eigen vakgebied.	Begrippen uit andere disciplines of contexten.
Vanwaaruit?	Het perspectief van de eigen beroepsgroep.	Het perspectief van de patiënt, de partner, de buurdiscipline.
Waarin?	De eigen vertrouwde omgeving en bestaande samenstelling.	Een andere context of gemengde samenstelling.
Effect	Versterkt de bestaande praktijk.	Maakt de bestaande praktijk zichtbaar en bespreekbaar.

Voor competentiecentra is dit geen theoretisch onderscheid. Het bepaalt hoe zij hun gesprekken, samenstelling en werkvormen ontwerpen.

Eerste-orde-reflectie helpt professionals beter worden in wat zij al doen. Zij verfijnt werkwijzen, verbetert oplossingen en versterkt het vermogen om bekende problemen aan te pakken. Die vorm is noodzakelijk voor kwaliteit en vakmanschap, en zij bevestigt tegelijk de bestaande praktijk: onderwerp, vocabularium, perspectief en context blijven dezelfde.

Tweede-orde-reflectie verandert bewust minstens één van die elementen. Zij introduceert andere begrippen, laat een vreemd perspectief toe, verplaatst het gesprek naar een andere omgeving, nodigt een andere discipline uit om mee te kijken. Daardoor verschuift niet alleen het antwoord, maar ook de vraag.

Wat als een natuurwet aanvoelde, blijkt een keuze. Wat als professioneel noodzakelijk gold, blijkt historisch gegroeid.

Tweede-orde-reflectie vraagt daarom **een tijdelijke vorm van vervreemding: de bereidheid om naar de eigen praktijk te kijken alsof zij van iemand anders is.**

Werkbezoeken, externe stemmen en multidisciplinaire samenstelling zijn daarmee concrete manieren om aan één van de vier bestanddelen te draaien. Zij brengen andere onderwerpen, begrippen, perspectieven of contexten binnen, en vergroten zo de kans dat professionele paden opnieuw zichtbaar worden.

Eén nuance hoort daarbij. Tweede-orde-reflectie is geen permanente staat van twijfel. Professionele gemeenschappen hebben stabiliteit, routines en gedeelde standaarden nodig om betrouwbaar te kunnen handelen. Wackerhausen vergelijkt professionele reflectie met het onderhouden van een zeilboot terwijl je vaart. Je haalt de boot niet uit elkaar; je herstelt één onderdeel, vervangt een plank, spant een lijn aan en blijft ondertussen varen. Reflectie maakt **periodieke herbronning** mogelijk: voldoende afstand om vanzelfsprekendheden opnieuw te onderzoeken, zonder het dagelijkse werk te verlammen.

3.4 Professionele tolerantie

Zodra een vreemd perspectief binnenkomt, verschijnt een tweede vraag: *hoe reageert een professionele gemeenschap wanneer haar vanzelfsprekendheden worden uitgedaagd?*

Professionele gemeenschappen ontwikkelen mechanismen om hun vakkennis, kwaliteit en identiteit te beschermen. Dat is een noodzakelijke functie; zonder zulke bescherming wordt een vak kwetsbaar voor willekeur. Niet elke nieuwe opvatting is waardevol en niet elke verandering is een verbetering. De relevante vraag gaat daarom over de mate van tolerantie voor vragen en perspectieven die afwijken van wat vertrouwd is.

Die tolerantie wordt zelden zichtbaar in openlijk conflict. Wackerhausen maakt hierover een scherpe observatie. Wie zegt nooit weerstand te hebben ervaren, kan gelijk hebben. Het is even goed mogelijk dat die persoon nooit iets heeft ingebracht dat de bestaande vanzelfsprekendheden werkelijk bevroeg. Een volledig conflictloze samenwerking kan wijzen op grote onderlinge tolerantie, maar evengoed betekenen dat iedereen dezelfde professionele socialisatie deelt.

Daarom is één vraag vaak verhelderend: *wanneer heeft hier voor het laatst iemand iets gezegd dat ongemakkelijk was, en wat gebeurde er toen?*

Het antwoord maakt zichtbaar of afwijkende inbreng werkelijk wordt onderzocht, of alleen wordt geduld zolang zij geen gevolgen heeft. Een groep hoeft het met een afwijkende stem niet eens te zijn. Zij onderzoekt de inhoud ervan voordat zij die afwijst.

3.5 Productieve disharmonie

Daar hangt een ontwerpkeuze aan vast. Diversiteit in perspectieven, begrippen en opvattingen werkt als een professionele genenpool: zij bepaalt mee of een beroepsgroep zich kan aanpassen wanneer de omstandigheden veranderen.

Een groep die alle verschillen wegwerkt, wordt efficiënter onder bekende omstandigheden. De leden begrijpen elkaar snel, gebruiken dezelfde taal en vertrekken vanuit gedeelde aannames. Die efficiëntie heeft een prijs: verandert de context, dan beschikt de groep over minder alternatieve perspectieven om haar praktijk opnieuw te bekijken.

Productieve disharmonie is daarom geen probleem voor professionele ontwikkeling; zij is één van haar voorwaarden. Zij vraagt geen conflict en geen vertraagde besluitvorming. Zij vraagt dat relevante verschillen niet voortijdig worden weggewerkt, en dat een verschil in perspectief voldoende ruimte krijgt om zichtbaar te maken welke aannames, belangen en professionele gewoonten in het geding zijn.

Daar ligt een kernfunctie van competentiecentra. Zij organiseren ontmoetingen tussen perspectieven die elkaar in de dagelijkse praktijk niet vanzelf tegenkomen: ervaringen uit verschillende diensten komen samen, disciplines kijken met elkaar mee, en de interne praktijk wordt verbonden met externe kennis.

Daarmee creëren competentiecentra de omstandigheden waarin een professioneel domein zichzelf kan onderzoeken, aanpassen en vernieuwen. **Professionele blindheid begint waar niemand nog iets onverwachts zegt.**

BEWEGING II · DELEN 4 EN 5

DIAGNOSE

Waar de spanning tussen diensten en competentiecentra vandaan komt, en waarom zij in dit huis scherper wordt gevoeld. Deel 4 benoemt vier samenhangende breuklijnen. Deel 5 plaatst die diagnose in onze eigen context, met wat andere huizen doen en met wat wij in 2023 zelf hebben overgenomen.

4 DIAGNOSE: SPANNING ALS ONTWERPVRAAG

In één zin. De spanning tussen diensten en competentiecentra volgt uit vier samenhangende breuklijnen: mandaat, inzet, besluit en proces. Herstel begint bij de dragende laag: het mandaat.

Waarom dit ertoe doet. Deel 3 verklaart waarom grenzen blijven bestaan wanneer niemand ze onderhoudt. Dit deel verklaart waarom spanning ontstaat, ook wanneer iedereen wél wil. Wat zich in de dagelijkse praktijk toont als wisselende betrokkenheid, frustratie of moeizame samenwerking, laat zich preciezer benoemen. Veel van die spanning komt voort uit de manier waarop de organisatie is ingericht. Dit deel levert de diagnose waarop alle ontwerpvoorstellen in deze nota steunen, en verklaart waarom sommige interventies weinig effect hebben zolang de onderliggende structurele vragen onbeantwoord blijven.

Wat hieruit volgt. De organisatie kiest expliciet hoe de verticale en de horizontale as zich tot elkaar verhouden, afhankelijk van de opgave, het risicoprofiel en het gewenste resultaat.

4.1. De matrix als ontwerpkeuze

Competentiecentra en diensten vormen samen een matrixorganisatie. Medewerkers bewegen zich tegelijk binnen twee logica's. In de hiërarchische lijn wordt de dagelijkse zorg georganiseerd. In de professionele lijn komen expertise, kwaliteit en ontwikkeling samen.

Die dubbele aansturing vloeit voort uit de aard van de opdracht. Een complexe zorgorganisatie beantwoordt tegelijk twee vragen: hoe waarborgen we vandaag veilige en betrouwbare zorg, en hoe ontwikkelen we de kennis en standaarden die morgen nodig zijn? Beide zijn noodzakelijk, en geen van beide kan duurzaam ondergeschikt worden gemaakt aan de andere.

Volgens Galbraith past de structuur van een organisatie bij de complexiteit van haar beslissingen. **Wanneer zowel klinische kwaliteit als operationele haalbaarheid richtinggevend zijn, is een matrixstructuur het logische antwoord.**

De matrix lost de spanning niet op. Ze organiseert haar.

4.2. Exploitatie en exploratie: spanning als systeemkenmerk

Waar twee legitieme logica's samenkomen, ontstaat spanning. **Spanning volgt uit het ontwerp.**

Zij markeert precies de plek waar de kernopgave van de organisatie zich afspeelt: **de matrixknoop**. Daar wordt voortdurend afgewogen tussen kwaliteit en continuïteit, tussen professionele ontwikkeling en operationele haalbaarheid.

March beschrijft die spanning als die tussen **exploitatie** en **exploratie**. Organisaties voeren betrouwbaar uit wat vandaag nodig is én investeren in de kennis, praktijken en standaarden van morgen. Beide opdrachten doen een beroep op dezelfde mensen, dezelfde tijd en dezelfde aandacht.

Bij ons zit die paradox in het organigram verweven. **Het zwaartepunt van de exploitatie ligt bij de diensten:** bezetting, roosters, continuïteit, betrouwbaarheid van het hier en nu. **Het zwaartepunt van de exploratie ligt bij de competentiecentra:** ontwikkeling van het vakgebied, nieuwe zorgpaden en professionele standaarden.

Wat O'Reilly en Tushman **structurele ambidexteriteit** noemen, het vermogen twee dingen tegelijk goed te doen, is bij ons een eigenschap van de structuur zelf.

De opgave is niet spanning weg te nemen, maar haar voldoende productief te houden om kwaliteit én continuïteit tegelijk te dragen.

4.3. Wanneer spanning naar mensen verschuift

Zolang spanning niet expliciet georganiseerd wordt, verschuift zij van de structuur naar de mensen. Dan ontstaan twee voorspelbare patronen. **Deze twee patronen hebben dezelfde oorzaak: spanning die de structuur niet opvangt.**

DE OPERATIONELE REFLEX. Acute en zichtbare noden krijgen voorrang op ontwikkeling en kwaliteitswerking. Werk voor competentiecentra schuift naar de marge en gebeurt wanneer tijd overblijft, terwijl die tijd zelden werkelijk beschikbaar is.

DE AFSTEMMINGSVAL. Wanneer bevoegdheden en besluitregels onduidelijk blijven, groeit de behoefte aan overleg sneller dan het vermogen om beslissingen te nemen. Er wordt meer afgestemd, meer besproken en meer verduidelijkt, zonder dat eigenaarschap of voortgang toenemen. Het gesprek wordt dan een doel op zich.

4.4. Vier breuklijnen in één systeem

Die spanning laat zich nauwkeuriger benoemen. Conway observeerde dat organisaties systemen voortbrengen die een afdruk zijn van hun communicatiestructuur. Langs die lijn tekenen zich vier opeenvolgende breuklijnen af. **Elke breuklijn verzwakt de volgende.**

Breuklijn	Wat er structureel ontbreekt	Hoe het zich uit
Mandaatbreuk	Resultaatverantwoordelijkheid zonder beslissingsmacht.	Vooruitgang vraagt voortdurende onderhandeling
Inzetbreuk	Geen gedeelde spelregels voor prioritering en inzet	Afweging tussen dienst en competentiecentrum gebeurt ad hoc
Besluitbreuk	Onduidelijkheid over wie beslist, waar en op welke gronden	Beslissingen vertragen of blijven uit

Breuklijn	Wat er structureel ontbreekt	Hoe het zich uit
Procesbreuk	Geen escalatie-, opvolg- of monitoringsmechanisme	Dossiers vallen stil zonder duidelijke aanleiding

De volgorde is essentieel. Zolang verantwoordelijkheid niet gekoppeld is aan voldoende mandaat, blijven afspraken afhankelijk van goodwill. Zolang besluitvorming onduidelijk is, worden conflicten uitgevochten via uithoudingsvermogen in plaats van via governance. En zolang de onderliggende breuken bestaan, lossen betere procesafspraken weinig op.

Herstel verloopt daarom van beneden naar boven. Wie begint bij conflicthantering terwijl mandaat en besluitvorming onduidelijk blijven, behandelt symptomen.

4.5 Werkbare asymmetrie

De vier breuklijnen leiden naar één fundamentele vraag: *welke verhouding tussen de verticale en de horizontale as maakt de matrix werkbaar?*

Twee ontsporingen komen daarbij regelmatig voor. De eerste is de **verleiding van volledige symmetrie**: iedere lijn krijgt evenveel gewicht in iedere beslissing, met traagheid en besluiteloosheid als resultaat. De tweede is **ongereguleerde groei van de matrix**: mandaten vervagen, overlegstructuren stapelen zich op en informele macht neemt het over van expliciete keuzes.

Een werkbare matrix vraagt niet dat beide lijnen overal even zwaar wegen. Een werkbare matrix vraagt vooral **doordachte asymmetrie**: een verhouding waarin per vraagstuk vastligt welke lijn de primaire beslissingsverantwoordelijkheid draagt en welke lijn toetst, verrijkt of ontwikkelt.

Welke lijn doorweegt, verschilt naargelang de opgave. Waar patiëntveiligheid, continuïteit en snelheid centraal staan, ligt het zwaartepunt dicht bij de hiërarchische lijn. Waar professionele normering, expertiseontwikkeling en kwaliteitsbeleid centraal staan, ligt het dicht bij de professionele lijn. **Een volwassen matrix maakt die verschuivingen expliciet en legt ze vooraf vast.**

De spanning tussen diensten en competentiecentra bewijst dat de matrix haar werk doet. De uitdaging ligt in het voorzien van voldoende mandaat, besluitkracht en structuur om die spanning productief te maken.

De vraag is dus niet wie meer macht moet krijgen. De vraag is of de huidige verhouding tussen beide lijnen nog aansluit bij de opdracht die we willen realiseren.

4.6 Vier instrumenten, vier doorsneden

Deze nota gebruikt vier analysekaders. De breuklijnen stellen de diagnose, de dimensies wijzen de richting, de componenten beschrijven de inrichting en de praktijken tonen het leven. Samen vormen zij vier doorsneden van dezelfde werkelijkheid.

Instrument	Waar	Welke vraag het beantwoordt
De vier breuklijnen	Deel 4	Waar zit het probleem?
De vier maturiteitsdimensies	Deel 7	Waar staat dit centrum, en wat is de volgende stap?
De zeven kerncomponenten	Deel 8	Wat moet er minimaal zijn?
De elf praktijken	Deel 10	Gebeurt er ook iets?

5 ONS ZIEKENHUIS: TRADITIE, TRANSITIE EN PROFESSIONELE AUTONOMIE

In één zin. In een professionele organisatie ontstaat gezag uit professionele geloofwaardigheid, meer dan uit positie.

Waarom dit ertoe doet. De spanning uit deel 4 bestaat in elke matrixorganisatie. Hoe sterk zij wordt ervaren, hangt af van de context. Drie kenmerken van UPC maken die spanning tegelijk groter en belangrijker: een professionele organisatievorm, een sterke traditie, en een omgeving in verandering. Een elegant organigram volstaat daarom niet; het ontwerp moet professioneel geloofwaardig zijn.

Wat hieruit volgt. Ontwerpkeuzes worden eerst verantwoord vanuit de spanning die zij helpen dragen, en pas daarna vanuit de structuur die zij creëren. Een horizontale opdracht krijgt slechts slagkracht wanneer professionele legitimiteit gepaard gaat met voldoende zeggenschap.

5.1 Waar gezag vandaan komt

UPC functioneert als een professionele organisatie. Veel medewerkers beschikken over gespecialiseerde expertise, werken met een grote mate van autonomie en zijn gewend hun handelen inhoudelijk te verantwoorden.

Dat heeft een belangrijke consequentie. Gezag wordt hier slechts gedeeltelijk ontleend aan positie of hiërarchie. Minstens even zwaar weegt de erkenning die iemand krijgt van collega's en vakgenoten. Formeel gezag en professionele legitimiteit versterken elkaar; elk van beide blijft op zichzelf te zwak.

Voor competentiecentra heeft dat onmiddellijke gevolgen. Hun duurzaamheid hangt minder af van hun plaats op een organigram dan van hun vermogen om standaarden, kennis en praktijken te ontwikkelen die professionals als waardevol ervaren. In een professionele organisatie is de sterkste vorm van gezag deze zin: *dit zien wij professioneel als de juiste standaard*.

De opdracht van een competentiecentrum omvat daarom, naast het organiseren van kennis, het opbouwen van professionele legitimiteit naast de lijn.

5.2 Een organisatie tussen traditie én transitie

UPC draagt een lange klinische traditie. Expertise werd er over jaren opgebouwd, doorgegeven en verfijnd. Tegelijk verandert de omgeving voortdurend: nieuwe zorgmodellen ontstaan, rollen verschuiven, specialisaties verdiepen, en de verwachtingen van patiënten, professionals en partners evolueren.

Competentiecentra staan op het kruispunt van die twee bewegingen. Zij worden soms voorgesteld als motoren van verandering, en dat is de helft van hun opdracht. **De tweede helft weegt even zwaar: bewaren wat behouden moet blijven.** Dat is precies wat deel 1 curatorschap noemt; een collectie in stand houden én nieuw werk introduceren.

Een competentiecentrum dat uitsluitend als verandermotor wordt gezien, roept weerstand op. Een competentiecentrum dat traditie draagt én vernieuwing mogelijk maakt, krijgt een bredere en duurzamere legitimiteit. De ontwerp vraag luidt dus hoe traditie en vernieuwing tegelijk gedragen worden.

5.3 Universitair karakter en hoog-autonome professionals

De combinatie van professionele autonomie, traditie en verandering verhoogt de eisen aan elk organisatieontwerp.

Professionals aanvaarden een structuur zelden omdat zij elegant oogt of elders succesvol bleek. Zij willen begrijpen welke spanning het ontwerp probeert te dragen, welke aannames eraan ten grondslag liggen en waarom het in hun context werkt. Dat maakt ontwerpen veeleisender. Tegelijk is het een sterkte: wanneer een model inhoudelijk coherent is, aansluit bij de praktijk en professioneel geloofwaardig wordt gevonden, ontstaat een uitzonderlijk sterk draagvlak. Mensen volgen het dan omdat het zinvol is.

Juist daarom vertrekt deze nota van spanningen in plaats van functies, organigrammen of overlegstructuren. **Structuren krijgen pas betekenis wanneer duidelijk is welke spanning zij moeten helpen dragen.**

5.4 Waar deze vormen elders voorkomen

Competentiecentra zijn geen vinding van dit huis. Zorg- en kennisorganisaties gebruiken uiteenlopende vormen om expertise dwars op hun lijnorganisatie te organiseren: vakgroepen, academische departementen, professionele netwerken, commissiestelsels en academische werkplaatsen.

Ondanks hun verschillen delen zij één kenmerk: **elke vorm die werkelijk iets kan afdwingen, beschikt over zeggenschap over mensen of over geld.**

De vormen zonder dat scharnier moeten hun doelen via invloed bereiken. De vergelijking levert daarom geen menukaart op, maar één terugkerend ontwerp principe: mandaat volgt zeggenschap. Wie een horizontale as een opdracht geeft zonder die zeggenschap, kiest bewust voor invloed in plaats van sturing.

5.5 Onze eigen voorgeschiedenis

Er is nog iets dat ons huis kenmerkt, en dat is ons eigen dossier. De vraag die deze nota beantwoordt, is hier al eens gesteld.

In maart 2023 legde een nota aan het directiecomité de sturing en de ploegopstelling van de organisatie vast. Zij ontleende haar vocabulaire aan het model dat Henrik Kniberg omstreeks 2012 bij Spotify beschreef: squads die het werk doen, tribes die hen groeperen, en chapters die de vakinhoud dragen dwars op de squads heen. Voor een huis dat zocht naar een manier om expertise naast de lijn te organiseren, was dat een begrijpelijke keuze, en het was de juiste vraag.

Eén element van dat model ging bij de overname verloren. In het origineel was de chapter lead de lijnverantwoordelijke van zijn chapterleden: hij voerde hun functioneringsgesprekken en beschikte mee over hun tijd. **Daar zat het scharnier.** De horizontale as had zeggenschap over mensen, en dus over uren. In onze versie werden chapters beschreven als louter gericht op inhoudelijke ontwikkeling en innovatie ten dienste van de doelstellingen van de squads en tribes. **De tekening bleef, het scharnier viel weg.**

Wat daarop volgt, is voorspelbaar, en het is elders gedocumenteerd. Kniberg noemde zijn eigen beschrijving uitdrukkelijk een momentopname van één organisatie op één moment. Jeremiah Lee beschreef in 2020 wat er in diezelfde omgeving van overbleef: conflicten zonder duidelijke eigenaar, en chapters die hun ontwikkelopdracht niet realiseerden omdat lopend werk nu eenmaal voorgaat.

Wackerhausen verklaart wat er dan met de energie gebeurt: een gemeenschap die haar standaard nergens kan laten gelden, zet die energie om in identiteitswerk. **Wat van buitenaf leest als protectionisme bij sommige competentiecentra, is de voorspelbare uitkomst van een ontwerp dat hun een opdracht gaf zonder mandaat.**

De nota van 2023 hoeft daarom niet weerlegd te worden; zij wordt afgemaakt. Haar eigen besluitvoorstel luidde dat het directiecomité het voorstel zou bespreken, en zij bevatte een tabel met de titel *Wat verandert er?* Vier kolomkoppen, en één lege rij. **Dat is Conway in zijn letterlijkste vorm: een ontwerpbeslissing die de communicatiestructuur nooit bereikt, kan de organisatie niet vormgeven.** Die vier koppen zijn overigens nog steeds de juiste vier.

Sindsdien beweegt het dossier consequent in één richting. In februari 2025 kreeg de horizontale as zeggenschap over mensen. In december 2025 kreeg die zeggenschap een naam - instructierecht - en een procedure. Deze nota levert de laag die daaronder ontbrak: de bestaansreden waaruit dat instructierecht volgt.

Drie nota's over drie jaar, één beweging: van faciliteren via meebeslissen naar pragmatisch instructierecht.

Wat die drie nota's onbeantwoord lieten, is dezelfde vraag waarop de vier breuklijnen uitkomen: wie draagt deze opdracht eigenlijk? Het volgende deel begint daar.

BEWEGING III · DELEN 6 TOT 8

ONTWERP

Wie de opdracht draagt, hoe volwassen een centrum is, en hoe wij het inrichten. Deze drie delen leveren het lidmaatschap, de maturiteitslens en de governance-architectuur waarmee de breuklijnen zich laten herstellen.

6 LIDMAATSCHAP: WIE DE OPDRACHT DRAAGT

***In één zin.** Verantwoordelijkheid wordt pas organiseerbaar wanneer duidelijk is wie lid is, wat dat lidmaatschap vraagt en welke verschillende vormen van betrokkenheid mogelijk zijn.*

***Waarom dit ertoe doet.** Zolang lidmaatschap een impliciete combinatie blijft van betrokkenheid, beschikbaarheid en goodwill, zweven afspraken over mandaat, capaciteit en governance boven een onbepaalde groep. Een gelaagd model maakt verschillen in tijd, engagement en verantwoordelijkheid expliciet en draagbaar.*

***Wat hieruit volgt.** Het ziekenhuis ontwikkelt samen met de competentiecentra een expliciet en gelaagd model van lidmaatschap, kiest daarvoor één taalregister en past dat consequent toe.*

6.1 Lidmaatschap als expliciete rol

Vandaag functioneert lidmaatschap als een impliciete combinatie van betrokkenheid, beschikbaarheid en goodwill. Wij benoemen het zelden als een expliciete rol met verwachtingen, verantwoordelijkheden en wederkerigheid. Dat maakt engagement kwetsbaar en moeilijk vol te houden.

Conway's observatie helpt begrijpen waarom. Rollen die niet zichtbaar zijn ingebed in de communicatiestructuur van een organisatie blijven psychologisch en praktisch facultatief. Zij bestaan zolang iemand ze draagt en verdwijnen zodra andere prioriteiten zich opdringen.

Lidmaatschap betekent mee verantwoordelijkheid dragen voor collectieve output met impact buiten de eigen dienst. Dat maakt er een functionele rol van.

Zolang onduidelijk blijft wat die rol vraagt, wat zij verdringt en wat zij oplevert, verschuift de afweging volledig naar het individu. Betrokkenheid wordt dan situationeel, en continuïteit afhankelijk van persoonlijke inzet.

Wat zich aandient als een engagementprobleem, is in werkelijkheid een vraag van rolontwerp.

6.2 Lidmaatschap als dubbele verankering

Leden van een competentiecentrum brengen een volledige professionele praktijk mee. Die verankering in een dienst, team of vakgebied is precies wat het centrum nodig heeft. Tegelijk dragen zij verantwoordelijkheid voor iets dat groter is dan hun eigen werkplek.

Lidmaatschap vraagt daarom twee bewegingen tegelijk: verbonden blijven met de eigen praktijk en bijdragen aan een bredere professionele opdracht.

Een verbinding die alleen naar binnen kijkt, wordt een eiland. Een verbinding die alleen naar buiten kijkt, verliest haar grond.

Vanuit die logica is lidmaatschap een circulaire investering. Wat leden inbrengen, nemen zij mee terug naar hun eigen praktijk, en onderweg gaan perspectieven, taal en werkwijzen mee. Een competentiecentrum wordt zo een **circulatiepunt van expertise**.

Betrokkenheid zonder implementatie blijft advies; lidmaatschap reikt verder.

6.3 Een gelaagd model van lidmaatschap

Die logica vraagt een vorm van lidmaatschap die verschillen in tijd, engagement en verantwoordelijkheid draagt zonder rangorde te scheppen.

Sommige leden dragen structureel bij aan continuïteit, samenhang en besluitvorming. Anderen worden gericht betrokken wanneer hun expertise ertoe doet.

Beide bijdragen zijn noodzakelijk, maar verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid.

Twee voorwaarden maken zo'n model werkbaar. De structurele rol vraagt beschermde tijd en een expliciete termijn; zonder die twee blijft zij een naam. Tegelijk moet beweging tussen beide vormen mogelijk blijven. Beschikbaarheid, expertise en levensfase veranderen. Een model dat die beweging blokkeert, zet mensen vast in rollen die ooit passend waren.

In onze werkdocumenten circuleren daarvoor de termen *ankerlid* en *themalid*. De concrete uitwerking hoort bij het gesprek met de competentiecentra.

Betrokken hoeft niet te betekenen belast. Door verschillende vormen van participatie expliciet te organiseren, benutten we expertise zonder dat iedereen dezelfde mate van inzet opneemt.

6.4 Wat de dialoog beslecht

Het gelaagde model beantwoordt de vraag **hoe** lidmaatschap zich kan gedragen. De vraag **wie** lid is, hangt samen met de afbakening van het domein en hoort op de derde rij van de beslistafel: de dialoog met de competentiecentra.

Zes vragen liggen daar voor:

- volgt lidmaatschap de functie of het domein?
- zijn competentiecentra mono- of multidisciplinair?
- is lidmaatschap automatisch of expliciet opgenomen?
- hoeveel structurele leden zijn nodig?
- welke termijn is wenselijk?
- hoe organiseren we uitstroom en herpositionering?

Daar hoort een zevende bij, over taal.

Voor hetzelfde gelaagde model circuleren vandaag verschillende registers: *ankerlid en themalid, kern en flankerende kring, core team en extended network*.

Wie die begrippen door elkaar gebruikt, wekt de indruk dat het over verschillende modellen gaat.

Consistentie weegt zwaarder dan de keuze zelf.

Dit zijn ontwerp vragen, geen uitvoeringsvragen. Zij staan hier omdat de definitie uit deel 1 haar geloofwaardigheid mede ontleent aan wat zij openlaat.

Lidmaatschap is daarmee geen administratieve kwestie maar een ontwerpkeuze. Zonder expliciet lidmaatschap blijft ook verantwoordelijkheid impliciet.

7 MATURITEIT: VIER DIMENSIES

In één zin. Competentiecentra ontwikkelen zich langs vier samenhangende dimensies: mandaat, capaciteit, autoriteit en governance. Volwassenheid ontstaat wanneer die vier elkaar beginnen te versterken.

Waarom dit ertoe doet. Competentiecentra verschillen sterk van elkaar. Die verschillen zeggen weinig over kwaliteit en veel over ontwikkelingsfase. Een maturiteitslens verschuift het gesprek van oordeel naar ontwerp en maakt zichtbaar waar de hefboom per centrum ligt.

Wat hieruit volgt. Elk centrum situeert zichzelf op de vier dimensies en spiegelt dat beeld aan diensthoofden, directie en collega-centra.

7.1 Waarom een maturiteitslens

Competentiecentra zijn het mechanisme waarmee kwaliteit, expertise en professionele ontwikkeling organisatiebreed worden georganiseerd. In de praktijk verschillen zij sterk. Sommige functioneren vandaag als netwerk van betrokken professionals. Andere nemen al een duidelijke rol op in besluitvorming, kwaliteitsontwikkeling of externe vertegenwoordiging. Een eenvoudige ja-nee-vraag levert daarom weinig op.

De relevante vraag luidt: welke organisatorische draagkracht heeft dit competentiecentrum vandaag ontwikkeld?

Een maturiteitslens is een ontwikkelkader. Zij maakt zichtbaar welke mogelijkheden een centrum vandaag heeft, welke beperkingen daarbij horen en waar de belangrijkste hefboom voor verdere groei ligt.

7.2 Het model in één beeld

Centra worden langs meerdere lijnen tegelijk volwassen. Een centrum kan sterk staan in expertise en tegelijk weinig beslissingsruimte hebben, of over mandaat beschikken en over te weinig capaciteit om dat mandaat waar te maken. Vandaar vier samenhangende dimensies.

- **D1. BESLUITVORMINGSCAPACITEIT (mandaat).** In welke mate kan het competentiecentrum beslissingen nemen én realiseren?
- **D2. CAPACITEITSTOEWIJZING EN PRIORITERING (capaciteit).** In welke mate wordt tijd voor competentiecentrumwerking bewust georganiseerd en beschermd?
- **D3. PROFESSIONELE AUTORITEIT EN EXPERTISEPOSITIE (autoriteit).** In welke mate wordt het competentiecentrum erkend als gezaghebbende kennisbron?
- **D4. GOVERNANCE EN VERANTWOORDING (governance).** Hoe helder zijn besluitvorming, opvolging en verantwoordelijkheden georganiseerd?

Overzicht van de ontwikkelrichting van de vier dimensies:

Dimensie	Lage maturiteit	Middenniveau	Hoge maturiteit
D1 MANDAAT	Persoonlijke goodwill en onderhandeling; Invloed via expertise en relaties coördinator wordt geraadpleegd, beslist niet.	Formele rol en afspraken; beslissingsruimte wijkt bij operationele druk.	Erkend mandaat met afdwingbaarheid; toegang tot middelen; aan tafel waar richting wordt bepaald.
D2 CAPACITEIT	CC-tijd ontstaat ná dienstprioriteiten; spanning ligt bij het individu.	Intentionele afspraken over tijd en inzet; zichtbaar in roosters, en 'opofferbaar'.	CC-capaciteit als strategisch bezit: bewust toegewezen, actief beschermd en beheerd, meegewogen in evaluatie.
D3 AUTORITEIT	Erkenning volgt personen; ontsluiting ad hoc en persoonsafhankelijk.	Formele positionering; expertise wordt verbonden aan het centrum; adviezen herkenbaar en traceerbaar; vraaggestuurd.	Intern én extern referentiepunt; bepaalt de standaard in het domein.
D4 GOVERNANCE	Vrijblijvend overleg en consensus; besluiten impliciet; eigenaarschap diffuus; samenwerking rust op goodwill.	Voorspelbaar: benoemde rollen en besluitrechten, vaste rapportage, expliciete escalatieroutes.	Lerend systeem: uitkomsten sturen de inrichting bij; governance wordt periodiek geëvalueerd en bijgestuurd.

De vier paragrafen hierna beschrijven per dimensie waarom zij bestaat, waaraan u haar herkent, en welke verschuiving erin besloten ligt.

7.3 Besluitvormingscapaciteit: van relationele invloed naar structureel mandaat

Kernvraag: in welke mate kan het competentiecentrum beslissingen nemen én realiseren?

Bij lage maturiteit rust besluitvorming op expertise, overtuigingskracht en persoonlijke relaties. De coördinator wordt gehoord en geraadpleegd, zonder erkend beslissingsmandaat. Herkenbaar als: veel energie naar afstemming, bijna elke stap vraagt opnieuw onderhandeling, en de coördinator adviseert maar beslist niet.

Op middenniveau ontstaat institutionele ruggensteun. Rollen worden benoemd, verwachtingen explicieter en beslissingsruimte krijgt een herkenbare plaats. Herkenbaar als: benoemde bevoegdheden, mogelijke escalatie en afspraken die onder operationele druk toch kwetsbaar blijven.

Bij hoge maturiteit is besluitvorming structureel verankerd. Het centrum beschikt over een erkend mandaat, toegang tot middelen en een vaste plaats waar richtinggevend keuzes worden gemaakt. Herkenbaar als: beslissingen hebben gevolg, middelen zijn toegankelijk en het centrum zit aan tafel waar richting wordt bepaald.

De kernverschuiving loopt van "ik moet overtuigen" naar "ik kan beslissen binnen een erkend mandaat".

7.4. Capaciteitstoewijzing: van individuele loyaliteit naar collectief beheer

Kernvraag: hoe wordt tijd voor de werking van het centrum georganiseerd, beschermd en geprioriteerd?

Een coördinator blokkeert de donderdagvoormiddag voor haar centrum. In week één lukt het. In week twee valt er iemand uit en schuift zij door naar de namiddag. In week drie staat er een audit gepland en slaat zij over. In week vier vraagt zij zich af of blokkeren nog zin heeft. Niemand doet hier iets verkeerd. Er is alleen niemand die die voormiddag verdedigt behalve zichzelf.

Dat is de dimensie in één beeld. Beide assen doen een beroep op dezelfde mensen, dezelfde uren en dezelfde aandacht. Zonder expliciete afspraken komt die afweging bij het individu terecht.

Bij lage maturiteit ontstaat tijd voor het centrum pas nadat aan de verwachtingen van de dienst is voldaan. De werking hangt af van persoonlijke goodwill en toevallige ruimte in agenda's. Herkenbaar als: last-minute afmeldingen, weinig voorbereidingstijd, projecten die stilvallen tijdens drukke periodes en schuldgevoel over tijdsbesteding.

Op middenniveau erkent de organisatie dat dit werk tijd vraagt en dus tijd krijgt. Er komen expliciete afspraken over inzet, zichtbaar in roosters. De onderliggende spanning blijft: stijgt de operationele druk, dan wordt beschermde tijd teruggevorderd. Herkenbaar als: vaste momenten in agenda of rooster, afgesproken inzet (bijvoorbeeld een deel van een VTE), minder ad-hocverschuivingen en beschermde tijd die bij drukte alsnog sneuvelt.

Bij hoge maturiteit geldt capaciteit als een strategisch middel van de organisatie. Tijd voor competentiecentrumwerking is een investering in kwaliteit, expertise en ontwikkeling: bewust toegewezen, actief beschermd en periodiek herijkt. Herkenbaar als: diensthoofden volgen doelstellingen en voortgang actief mee op, capaciteit weegt mee in prioritering en planning, strategische projecten krijgen tijdelijk extra ruimte en bijdragen worden zichtbaar gewaardeerd.

De kernverschuiving loopt van "ik probeer tijd te maken" naar "de organisatie maakt hier bewust tijd voor vrij".

7.5. Professionele autoriteit: van persoon naar instituut

Kernvraag: in welke mate wordt het competentiecentrum erkend als gezaghebbende kennisbron binnen zijn domein?

Elke organisatie beschikt over expertise. De relevante vraag is hoe die expertise georganiseerd is. Blijft zij verbonden aan individuele professionals, dan rust het gezag van het domein op personen. Een volwassen centrum verlegt dat zwaartepunt naar een collectief dat kennis ontwikkelt, bewaart, verbindt en overdraagt.

Bij lage maturiteit volgt erkenning personen. Collega's weten wie veel expertise heeft en zoeken die persoon rechtstreeks op. Het centrum vormt hoogstens een los verband rond enkele sterke professionals. Herkenbaar als: "het werkt omdat X het trekt", expertise is bekend maar nauwelijks gedocumenteerd, vragen gaan rechtstreeks naar personen en personeelsswissels leiden tot zichtbaar verlies.

Op middenniveau ontwikkelt het centrum een herkenbare positie. Adviezen en standpunten worden verbonden aan het centrum, en de organisatie ziet het als aanspreekpunt voor het domein. Het zwaartepunt ligt nog bij ondersteuning op vraag. Herkenbaar als: beleidsdocumenten verwijzen naar het centrum, adviezen zijn herkenbaar, herhaalbaar en traceerbaar, en opleiding en ondersteuning verlopen via het centrum.

Bij hoge maturiteit fungeert het centrum als erkend referentiepunt. Het helpt bepalen wat binnen het domein als goede praktijk geldt en draagt bij aan standaarden, opleidingen, zorgmodellen en professionele normering. Dat gezag berust op professionele geloofwaardigheid. Herkenbaar als: het centrum geldt intern als referentiepunt, externe partners zoeken aansluiting, standaarden worden vanuit het centrum ontwikkeld en het domein behoudt continuïteit bij personeelsswissels.

De kernverschuiving loopt van "zij heeft veel kennis" naar "dit is de standaard die we vanuit het centrum hanteren".

7.6. Governance en verantwoording: van vrijblijvend overleg naar lerend systeem

Kernvraag: hoe helder zijn besluitvorming, opvolging en verantwoordelijkheid georganiseerd?

Deze dimensie verschilt van de drie vorige. Waar besluitvorming, capaciteit en autoriteit beschrijven wat een centrum kan, beschrijft governance wat er gebeurt wanneer belangen, perspectieven of prioriteiten botsen.

Governance is de lijm van de matrix.

Zonder expliciete afspraken blijft de matrix een aantrekkelijk idee dat bezwijkt zodra de spanning voelbaar wordt.

Bij lage maturiteit rust samenwerking op goede wil en consensus. Besluiten worden zelden vastgelegd, verantwoordelijkheden blijven onduidelijk en opvolging hangt af van individuele inzet. Conflicten blijven hangen en discussies keren terug. De matrix bestaat dan vooral als organigram; in de praktijk wint de sterkste stem, de hoogste positie of de meest dringende vraag. Herkenbaar als: dezelfde discussies keren terug, besluiten blijven impliciet, eigenaarschap is diffuus en één kritische stem kan beweging blokkeren.

Op middenniveau wordt governance voorspelbaar. Rollen, besluitrechten en verantwoordelijkheden worden benoemd; er zijn vaste overlegmomenten, rapportagelijnen en escalatieroutes. De organisatie erkent dat spanning tussen beide assen normaal is. De vraag verschuift van "hoe vermijden we conflict?" naar "hoe behandelen we conflict wanneer het ontstaat?". Herkenbaar als: benoemde besluitrechten, gekende escalatiepaden, rapportage op vaste momenten en afspraken die meestal worden nageleefd.

Bij hoge maturiteit evolueert governance naar een lerend systeem. Niet alleen beslissingen worden opgevolgd, ook hun effecten. De vraag verschuift van "hebben we gedaan wat we afspraken?" naar "levert dit nog op wat we willen bereiken?". Spanningen worden een informatiebron en de inrichting wordt periodiek herbekeken.

De matrix wordt hier actief onderhouden in plaats van passief bewoond.

Herkenbaar als: resultaten worden systematisch besproken, governance wordt periodiek herijkt, prestaties beïnvloeden middelen en prioriteiten, en conflicten leiden tot leren.

De kernverschuiving loopt van "we hebben het besproken" naar "we hebben het gerealiseerd, geëvalueerd en bijgestuurd".

7.7. Samenhang tussen de dimensies

De vier dimensies versterken of verzwakken elkaar.

- Mandaat zonder capaciteit blijft theorie.
- Capaciteit zonder mandaat blijft vrijblijvend.
- Autoriteit zonder governance blijft persoonsgebonden.
- Governance zonder autoriteit verwordt tot procedure.

Zij laten zich lezen als twee koppels.

D1 en D2 gaan over slagkracht: kan het centrum handelen en realiseren?

D3 en D4 gaan over duurzaamheid: blijft expertise bestaan, en wordt zij omgezet in collectieve richting?

Een centrum kan tijdelijk verder staan op de ene dimensie dan op de andere. Op langere termijn bepalen de dimensies elkaars draagkracht.

Een volwassen competentiecentrum ontstaat doordat de vier dimensies elkaar beginnen te versterken.

Daarom lezen we maturiteit als een ontwikkelpad. De relevante vraag is niet hoe hoog een centrum scoort, maar of de dimensies voldoende in evenwicht groeien om samen kwaliteit, expertise en ontwikkeling te dragen.

7.8. Innovatie als gevolg van ontwerp

Innovatie wordt vaak voorgesteld als een kwestie van creativiteit, ondernemerschap of houding. Daarmee verhuist zij naar het niveau van het individu. Zij hoort bij het ontwerp.

Innovatie is in dit model wat gebeurt wanneer de vier dimensies samen genoeg draagkracht hebben bereikt: beslissingsruimte om te experimenteren, beschermde capaciteit om iets naast de dagelijkse werking te zetten, professionele legitimiteit om een nieuwe praktijk te laten landen, en een governance die leren en bijsturen toelaat.

Ontbreken die voorwaarden, dan verschaalt innovatie tot bevrogenheid. Zij gebeurt dan nog steeds - er is altijd iemand die iets probeert - en zij blijft gebonden aan de persoon die haar draagt. Wat die persoon opbouwt, vertrekt met hem. **Ontwerp bepaalt of vernieuwing haar bedenker overleeft.**

Zijn de voorwaarden er wel, dan wordt innovatie een collectieve en bestuurbare capaciteit. De houding volgt het ontwerp: professionals durven experimenteren omdat het systeem het toelaat, ondersteunt en beschermt.

Daaruit volgt een bruikbare regel voor onze investeringsbeslissingen. Zoals elk systeem wordt ook dit begrensd door zijn knelpunt: **het innovatievermogen van een centrum wordt bepaald door zijn zwakste dimensie.** Een centrum met veel legitimiteit en zonder beschermde tijd zal weinig vernieuwen, hoe bevrogen zijn leden ook zijn. De vraag *waar zetten we hier op in?* krijgt daarmee per centrum een aanwijsbaar antwoord.

8 ONTWERPPRINCIPES EN GOVERNANCE-ARCHITECTUUR

In één zin. *Expliciete governance is de voorwaarde voor professionele ruimte: heldere kaders ontlasten samenwerking en maken haar voorspelbaar.*

Waarom dit ertoe doet. *Maturiteit volgt uit bewuste ontwerpkeuzes. Zonder expliciete governance dragen individuen de spanning, verschuiven verantwoordelijkheden en ontstaat willekeur.*

Wat hieruit volgt. *Elk competentiecentrum beschikt over de zeven kerncomponenten; de drie ontwerpprincipes bepalen hoe die worden ingevuld.*

8.1 Waarom governance professionele ruimte creëert

Deel 7 beschrijft waar de competentiecentra vandaag staan. Dit deel beschrijft wat hen vooruithelpt.

Heldere kaders zijn een vorm van vertrouwen. Juist omdat wij professionals vertrouwen, hebben zij recht op duidelijkheid. Ambigüiteit creëert onzekerheid en stille machtsstrijd; helderheid creëert rust, focus en ruimte om te werken.

Waarom dat hier zo scherp speelt, laat zich met Elinor Ostrom verklaren. Zij toonde hoe gemeenschappen gedeelde hulpbronnen duurzaam beheren zonder hiërarchie en zonder markt. In onze context is die analogie bijna letterlijk. Mensen, tijd en aandacht vormen de gedeelde bron. De dienst claimt die middelen voor continuïteit, het competentiecentrum voor ontwikkeling, en beide claims zijn legitiem.

Ostroms les is eenvoudig: zonder spelregels, zichtbaarheid en consequenties raakt een gedeelde bron uitgeput, of blokkeert zij doordat partijen elkaar neutraliseren.

De medewerker is in dat scenario tegelijk de bron en het slachtoffer.

8.2 Drie ontwerpprincipes

EXPLICIETE GOVERNANCE BOVEN IMPLICIETE SAMENWERKING.

Ook teams die elkaar volledig vertrouwen krijgen conflicten over prioriteit, capaciteit en richting. Zonder afgesproken manier om die te behandelen worden conflicten vermeden, gepersonaliseerd of opgestapeld.

Goede wil is bovendien geen onuitputtelijke bron. Informele samenwerking vraagt voortdurende relationele afstemming, en dat put uit. Expliciete governance ontlast de samenwerking, maakt haar voorspelbaar en beschermt tegen willekeur.

Wie beslist, waarover en volgens welke regel, ligt vast vóór het conflict zich voordoet.

CAPACITEITSTOEWIJZING BOVEN GOODWILL.

Een structureel capaciteitsprobleem vraagt een structureel antwoord. Professionals beschikken over drie soorten tijd, en die drie gedragen zich verschillend.

Soort tijd	Wat het is	Wat ermee gebeurt
Contractuele tijd	De uren waarvoor iemand betaald wordt	Ligt vast
Geclaimde tijd	De uren waarvoor iemand verantwoordelijk wordt gehouden	Bijna altijd ruimer dan de contractuele
Discretionaire tijd	Wat daarna overblijft	Verdwijnt het eerst

Tijd voor het competentiecentrum wordt toegewezen en beschermd. De portefeuille volgt de capaciteit.

PROCESMACHT BOVEN POSITIEMACHT.

Een ziekenhuis is wat Mintzberg een professionele bureaucratie noemt: het vakmanschap van de uitvoerders weegt zwaar en gezag berust in belangrijke mate op expertise.

Een coördinator ontleent gezag daarom in de eerste plaats aan de kwaliteit van het proces dat hij organiseert.

- Vooraf: een agenda met een expliciet doel per punt en documenten die op voorhand circuleren.
- Tijdens: perspectieven ordenen vóór de beslissing, tijd bewaken en expliciet maken hoe beslist wordt.
- Nadien: besluiten documenteren en opvolgen.

Een zwakke coördinator beantwoordt elke inhoudelijke vraag zelf. Een sterke richt het proces zo in dat de groep de antwoorden vindt.

Procesmacht kent grenzen. Structurele niet-naleving, fundamentele richtingsconflicten en het terugvorderen van toegezegde capaciteit vragen escalatie naar formeel gezag.

Gezag ontstaat hier uit de kwaliteit van het proces.

8.3 Zeven kerncomponenten

De drie principes worden concreet in zeven componenten. Samen vormen zij de minimale infrastructuur van een werkend competentiecentrum.

Component	Kernvraag	Wat gebeurt zonder
Heldere afbakening	Waarover gaat dit competentiecentrum wel en niet?	Diffuse verantwoordelijkheid en territoriumconflict
Realistische regels	Zijn besluitvorming, tijd en overleg uitvoerbaar?	Governance die botst met de praktijk wordt genegeerd
Gedeeld eigenaarschap	Hebben leden mee vorm gegeven aan de spelregels?	Afspraken zonder procedurele rechtvaardigheid, en dus zonder draagvlak
Zichtbaarheid	Zijn bijdragen, voortgang en eigenaarschap zichtbaar?	Wat onzichtbaar blijft, wordt vrijblijvend
Proportionele consequenties	Wat gebeurt er wanneer afspraken niet worden nagekomen?	Niet-bijdragen wordt rationeel gedrag
Conflictresolutie	Hoe worden botsende belangen behandeld?	Conflicten etteren of worden gepersonaliseerd
Externe erkenning	Wordt het mandaat ook buiten het centrum erkend?	Een papieren constructie zonder slagkracht

Bij consequenties hoort één nuance. Zij dienen niet alleen het collectief, maar ook het individu. Wanneer structureel blijkt dat iemand een rol niet kan opnemen, is herpositionering menselijker en professioneler dan iemand vast te houden in een bron van stress en schuldgevoel.

Rolhelderheid is hier de sanctie.

8.4 Samenhang

Een centrum met duidelijke grenzen en zonder zichtbaarheid blijft vrijblijvend. Een centrum met consequenties en zonder gedeeld eigenaarschap voelt autoritair. Een centrum dat alles heeft behalve externe erkenning blijft een papieren tijger. De kracht zit daarom niet in afzonderlijke componenten, maar in een architectuur waarin mandaat, capaciteit, autoriteit en governance elkaar versterken.

Professionele ruimte ontstaat dankzij governance.

Juist omdat verantwoordelijkheden, verwachtingen en spelregels helder zijn, kunnen competentiecentra duurzaam bijdragen aan kwaliteit, expertise en vernieuwing.

Governance beperkt professionele ruimte niet. Zij maakt haar mogelijk.

BEWEGING IV · DELEN 9 TOT 11

TOEPASSING EN HERIJKING

Welke ambitie wij per centrum kiezen, wat er werkelijk gebeurt tussen professionals, en hoe wij dat alles toetsen. De laatste beweging brengt de nota terug naar de bestaansreden waarmee zij begon, en organiseert de correctie die voorkomt dat dit ontwerp zelf een ingesloten pad wordt.

9 AMBITIE PER CENTRUM

In één zin. De gewenste maturiteit is een strategische keuze per domein, bepaald door het tempo waarin de kennis verandert en door het belang van dat domein voor het ziekenhuis.

Waarom dit ertoe doet. "We willen effectievere competentiecentra" is een wens. Dit deel vertaalt die wens naar keuzes over waar, hoe en wanneer we investeren. Zonder die vertaling krijgt elk centrum dezelfde behandeling voor een verschillende opgave.

Wat hieruit volgt. Ambitieniveaus worden in dialoog voorbereid door coördinator, diensten en directie, op directieniveau vastgelegd en periodiek herbevestigd.

9.1 Niet elk domein vraagt dezelfde ambitie

Niet elk domein vraagt dezelfde investering. Een stabiel en sterk geprotocolleerd domein kan uitstekend functioneren met een beperkte ontwikkelingsambitie. Een domein waarin kennis snel evolueert of dat strategisch bepalend is voor het ziekenhuis vraagt een hogere ambitie, en dus ook meer beschermde tijd.

Twee vragen bepalen die keuze:

- Hoe snel verandert de kennis in dit domein?
- Hoe sterk hangt de kwaliteit van onze zorg af van precies dit domein?



Figuur 1. Twee vragen bepalen de gewenste maturiteit: van een competentiecentrum als geheel, en van elk deelgebied daarbinnen. De nota plaatst geen centra in dit veld; dat gebeurt in gesprek met de coördinatoren en de betrokken diensthoofden.

De vier posities vormen geen rangorde.

Onderhouden is een volwaardige eindbestemming. **Borgen** is de positie die we het makkelijkst onderschatten: de kennis staat vast, maar continuïteit en overdracht zijn hier de kernopgave. **Volgen** vraagt weinig capaciteit en scherpe antennes. Alleen **Investeren** rechtvaardigt de volle inzet op alle vier de dimensies, en is daarmee de duurste keuze en dus de meest bewuste.

Deze twee vragen werken bovendien op twee schalen. Op het niveau van een competentiecentrum als geheel bepalen zij de ambitie die directie, diensten en coördinator samen vastleggen. Binnen een centrum bepalen zij hoe dat centrum zijn aandacht verdeelt over zijn deelgebieden. Een centrum dat als geheel in *Borgen* zit, kan één deelgebied hebben waar de kennis snel kantelt. Een centrum in *Investeren* heeft bijna zeker deelgebieden die met onderhoud toekunnen. Het raster is daarmee evengoed een instrument voor de coördinator en zijn leden als voor de directie. Dezelfde vragen, op hun eigen schaal.

9.2 Het gesprek dat het model mogelijk maakt

De eerste winst van het model is niet classificatie, maar gesprek.

In plaats van diffuse signalen zoals *"het loopt niet"* of *"het vraagt te veel energie"* ontstaat een gesprek over waar het knelpunt precies zit en welke hefboom werkelijk verschil maakt.

Dat gesprek wint aan scherpte wanneer meerdere perspectieven samenkomen. Wanneer een competentiecentrum zichzelf situeert op de vier dimensies en dat beeld naast dat van de diensthoofden en de directie legt, ontstaat leerpotentieel in plaats van oordeel.

Het interessante zit in het verschil.

Een centrum dat zichzelf lager inschat dan zijn omgeving, mist mogelijk erkenning voor stappen die het al heeft gezet. Een centrum dat zichzelf hoger inschat, botst mogelijk op beperkte zichtbaarheid van zijn impact of op een verwachtingskloof die nooit expliciet werd uitgesproken. **In beide gevallen wijst het verschil zelf de interventie aan.**

Het model wordt zo geen beoordelingsinstrument, maar een instrument voor gezamenlijke reflectie en gerichte keuzes.

9.3 Wat dit van de directie vraagt

Maturiteit bepalen is uiteindelijk een verdelingsvraag.

Zij bepaalt waar het ziekenhuis slagkracht opbouwt, waar stabiliteit volstaat en waar ruimte wordt gemaakt voor vernieuwing. Daarmee bepaalt zij ook waar beschermde tijd, ondersteuning en aandacht naartoe gaan. Om die reden kan deze keuze alleen op directieniveau worden gemaakt.

Wat wij van de competentiecentra vragen, namelijk een eerlijke inschatting van waar zij staan, verplicht ons tot dezelfde openheid. Dat vraagt een expliciete uitspraak over wat wij van elk centrum verwachten en over de middelen die daarbij horen.

Ambities die niet periodiek worden herbevestigd, zakken ongemerkt terug naar de standaard: iedereen evenveel, en dus niemand genoeg.

Gelijke behandeling lijkt rechtvaardig. Voor competentiecentra leidt zij vaak tot strategische verwaarlozing.

De vraag is daarom niet of alle competentiecentra dezelfde maturiteit moeten bereiken. De vraag is welke maturiteit, voor welk domein, op dit moment het meest bijdraagt aan de opdracht van het ziekenhuis.

10 PRAKTIJKGEMEENSCHAP: WAT ER TUSSEN PROFESSIONALS GEBEURT

In één zin. Een competentiecentrum legitimeert zich door het soort vragen dat er gesteld mag worden en door de praktijken die er circuleren.

Waarom dit ertoe doet. Het maturiteitsmodel kijkt naar structuur en beantwoordt de vraag of een competentiecentrum *kán* functioneren. Deze tweede bril stelt een andere vraag: gebeurt er ook iets?

Wat hieruit volgt. In het gesprek over een competentiecentrum weegt de aanwezigheid van levende praktijken even zwaar als de aanwezigheid van structuur.

10.1 Een tweede ontwerpbril: van structuur naar praktijk

Étienne Wenger beschrijft kennissamenkomsten als groepen die zich legitimeren via de praktijken die er circuleren. Uit dat kader volgt één bruikbare stelling:

Een praktijkgemeenschap legitimeert zichzelf door het soort vragen dat er gesteld mag worden.

Wanneer we de typische

praktijken van zo'n gemeenschap naast onze competentiecentra leggen - probleemoplossing, ervaring delen, materiaal hergebruiken, coördineren, twijfel uitspreken, documenteren en lacunes benoemen - ontstaat een diagnose-instrument.

De afwezigheid van die signalen wijst zelden op onwil. **Zij wijst op formalisering zonder leven, op overleg zonder leerwaarde.**

10.2 De 'families' en praktijken van een florerende kennissamenkomst

Onderstaande tabel vertaalt die praktijken naar onze context, in drie families. De middelste kolom bevat de typische uitspraak, de rechterkolom toont wat die praktijk betekent voor een competentiecentrum

Praktijk	Typische uitspraak	Betekenis voor een CC
Vragen en vastlopen		
Probleem oplossen	"Kunnen we hier samen naar kijken? Ik geraak er niet uit."	Er is ruimte om vast te lopen. Vastlopen is een collectief gegeven.
Informatie vragen	"Waar vind ik dat protocol of die procedure?"	Het CC is een vindplaats, geen archief dat enkel de coördinator kent.
Ervaring zoeken	"Heeft iemand al eens met zo'n situatie te maken gehad?"	Casuïstiek circuleert over dienstgrenzen heen; ervaring wordt gedeeld vóór ze verloren gaat.

Praktijk	Typische uitspraak	Betekenis voor een CC
Vertrouwen opbouwen	<i>“Ik leg het eerst even voor aan het CC voor ik het doe.”</i>	Het CC functioneert als klankbord vóór de beslissing.
Geheugen en hergebruik		
Materiaal hergebruiken	<i>“Ik heb dat vorig jaar uitgewerkt; pas het gerust aan.”</i>	Er is collectief geheugen. Kennis wordt niet telkens opnieuw uitgevonden.
Documenteren	<i>“Dit is nu de vijfde keer. Laten we het één keer goed vastleggen.”</i>	Van incident naar geheugen: het CC zet ervaring om in overdraagbare praktijk.
Coördineren en synergie	<i>“Kunnen we dit samen aankopen, plannen of organiseren?”</i>	Afstemming vanuit gedeelde praktijk. Verspilling wordt zichtbaar.
Grens en vernieuwing		
Argumenten opbouwen	<i>“Hoe pakken ze dit elders aan? Daarmee overtuig ik de directie.”</i>	Het CC bouwt legitimiteit op via vergelijking en externe referentie.
Nieuwe ontwikkelingen bespreken	<i>“Wat vinden jullie van die nieuwe methodiek? Werkt dat echt?”</i>	Innovatie wordt collectief getoetst.
Bezoeken	<i>“Mogen we eens komen kijken hoe jullie dat doen?”</i>	Het CC is een grensorgaan: het haalt praktijk van buiten naar binnen.
Lacunes benoemen	<i>“Wie weet wat — en wat missen we? Met wie moeten we verbinden?”</i>	Het CC durft benoemen wat het niet weet en wie er ontbreekt aan tafel.

10.3 Wat de drie families ons zeggen

Vragen zijn de eerste maatstaf. Een centrum dat richtlijnen produceert zonder ruimte te bieden voor twijfel, onzekerheid en onvolledigheid, verliest zijn functie als kennissamenleving. De bruikbaarste diagnosevraag luidt daarom: *welke vragen mogen hier gesteld worden, en welke blijkaar niet?*

Geheugen is het bewijs dat er iets circuleert. Waar materiaal hergebruikt wordt en ervaring wordt vastgelegd, bestaat collectief geheugen. Waar hergebruik ontbreekt, wordt kennis telkens opnieuw uitgevonden.

Coördinatie hoort in deze familie thuis. Afstemming vanuit gedeelde praktijk maakt afhankelijkheden zichtbaar en verspilling bespreekbaar, zonder dat het centrum iets beslist dat niet van hem is.

*Dat is de matrixlogica in één regel: **coördineren zonder te commanderen.***

Aan de grens haalt een centrum zijn legitimiteit. Werkbezoeken, vergelijking met andere ziekenhuizen en de collectieve toets van een nieuwe methodiek: een competentiecentrum is een grensorgaan dat externe praktijk naar binnen haalt en interne praktijk naar buiten toont.

Daar hoort het benoemen van lacunes bij: expliciet zeggen wat we niet weten, wat we niet kunnen en wie er aan tafel ontbreekt. Dat vraagt psychologische veiligheid en het is het duidelijkste teken van maturiteit dat een centrum kan geven.

10.4 Verhouding tot het maturiteitsmodel

De twee brillen meten verschillende dingen en corrigeren elkaar. Het maturiteitsmodel toont of de randvoorwaarden aanwezig zijn; de praktijkbril toont of er leven is binnen die randvoorwaarden.

Structuur zonder praktijk levert een correct ingerichte lege huls. Praktijk zonder structuur levert kwetsbare, persoonsgebonden excellentie.

De waarde van een competentiecentrum ligt in wat er tussen professionals gebeurt.

11 DE TOETS: VAN PRAKTIJK TERUG NAAR BESTAANSREDEN

In één zin. Een bestaansreden die niet periodiek aan de praktijk wordt getoetst, verschaalt tot een gewoonte.

Waarom dit ertoe doet. De redenering van deze nota loopt één richting uit: van bestaansreden naar ontwerp naar praktijk. Zonder een weg terug wordt de definitie uit deel 1 op termijn zelf een ingesleten pad, precies het mechanisme dat deel 3 beschrijft als blokkade voor samenwerking.

Wat hieruit volgt. Het huis organiseert drie toetsen op drie niveaus, en herijkt op basis daarvan zowel het ontwerp als deze nota.

11.1 Twee lussen in één systeem

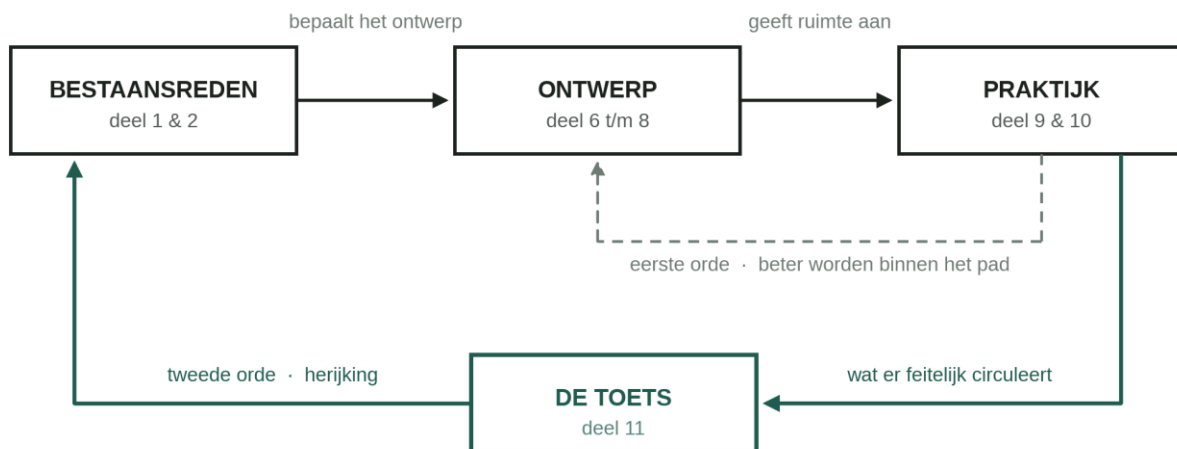
De delen 1 tot 10 beschrijven een keten: de bestaansreden bepaalt het ontwerp, het ontwerp geeft ruimte aan de praktijk. Wat die keten mist, is het mechanisme waarmee de praktijk terugslaat op wat eraan voorafging.

Argyris en Schön onderscheiden daarvoor twee lussen. Zij verhouden zich tot elkaar als de twee ordes van reflectie uit deel 3.

De binnenlus verbetert de uitvoering binnen het bestaande ontwerp: overleg loopt vlotter, agenda's worden scherper, afspraken worden bijgesteld.

De buitenlus stelt de bestaansreden zelf opnieuw ter discussie: doen deze centra nog wat wij dachten dat ze zouden doen? Klopt de afbakening van het domein nog, is de definitie uit deel 1 nog het beste antwoord op de opgave die vandaag voorligt?

	Binnenlus	Buitenlus
Vraag	Doen we de dingen beter?	Doen we nog de juiste dingen?
Wat verandert	Het ontwerp: afspraken, agenda's en werkvormen.	De bestaansreden en de afbakening van het domein.
Orde van reflectie	Eerste orde. Bevestigt het pad.	Tweede orde. Maakt het pad zichtbaar.
Ontstaat	Vanzelf, in de dagelijkse werking.	Wanneer ze expliciet wordt georganiseerd.



Figuur 2. Twee lussen, één systeem. Het onderscheid tussen reflectie van de eerste en de tweede orde uit deel 3 is hier het verschil tussen de gestippelde en de doorlopende weg terug.

11.2 Drie toetsen op drie niveaus

Niveau	De vraag	Het instrument	Ritme en eigenaar
Het centrum	Volgen onze middelen nog uit onze bestaansreden?	De oefening met twee kolommen	Jaarlijks, door de coördinator met het eigen team
De praktijk	Circuleert er leven binnen de structuur die we gebouwd hebben?	De praktijkscan op de elf praktijken uit deel 10	Jaarlijks, in dialoog met de aandachtsdirecteur
Het huis	Klopt onze ambitie nog met de opgave die voorligt?	De maturiteitsdialoog op de vier dimensies	Tweejaarlijks, met terugkoppeling aan het directiecomité

De drie toetsen zijn bewust licht gehouden. Zij vragen samen minder tijd dan één vermijdbaar misverstand over mandaat, en zij produceren het materiaal waarmee dat misverstand voorkomen wordt.

De drie instrumenten zelf worden uitgewerkt in de vervolgnota.

11.3 De herijkingsclausule

De toetsen hierboven onderzoeken de centra. Eén toets onderzoekt deze nota.

De definitie uit deel 1 wordt om de drie jaar getoetst aan wat de competentiecentra feitelijk doen en aan wat het huis op dat moment nodig heeft. De uitkomst komt op het directiecomité, samen met de vraag of de verhouding tussen de verticale en de horizontale as nog aansluit bij de opgave.

Dat is de eigen redenering van deze nota, toegepast op de nota zelf.

Wie een definitie vastlegt zonder haar toetsing te organiseren, legt een pad aan. Wie de toetsing meelevert, legt een kompas aan.

Middelen komen en gaan, de bestaansreden blijft. En een visienota is slechts een middel.

Slot. Wat deze nota vraagt

Deze nota beschrijft een kader en geeft bewust niet alle antwoorden. Mandaat, capaciteit en ambitieniveau worden per competentiecentrum in dialoog bepaald, met de coördinatoren, de diensten en de directie. Wie de antwoorden vooraf invult, ondergraaft precies het gedeelde eigenaarschap dat dit model als voorwaarde stelt.

Wat de tussenvorm vandaag kost

De keuze tussen adviseren en sturen wordt zelden expliciet gemaakt. Dat lijkt kosteloos. Dat is het niet.

Vandaag koppelen wij sturende verwachtingen aan adviserende bevoegdheden. Coördinatoren worden aangesproken op standaarden die zij niet kunnen afdwingen, en op resultaten die zij per dossier opnieuw moeten onderhandelen. Dat kost drie dingen. Het kost **tijd**, omdat elke stap opnieuw overleg vraagt. Het kost **expertise**, omdat wat één persoon opbouwt met die persoon vertrekt. En het kost **engagement**, omdat mensen die herhaaldelijk verantwoordelijkheid dragen zonder ruimte om te beslissen, zich terugtrekken naar wat zij wel kunnen beïnvloeden.

Van die drie is de laatste het duurst. **Expertise koop je terug. Engagement niet.**

De tussenvorm is vandaag de meest voorkomende situatie in ons huis. Zij verklaart een aanzienlijk deel van de spanning die deel 4 beschrijft.

Drie zaken vraagt deze nota wel

Eén. Instemming met de definitie. De definitie uit de kernbeslissing vervangt de omschrijving die vandaag op het intranet staat. De functiegebonden opdrachten uit die oude omschrijving krijgen een expliciete plaats elders in de organisatie.

Twee. Een uitspraak over de as. Adviseren de competentiecentra, of sturen zij? Deze vraag beantwoordt het directiecomité. Zoals 5.5 laat zien, is zij niet nieuw. In februari 2025 kreeg de horizontale as zeggenschap over mensen. In december 2025 kreeg die zeggenschap een naam en een procedure. Wat hier voorligt is de

bevestiging van een lijn die het directiecomité zelf al tweemaal heeft uitgezet, nu met de bestaansredenen eronder. Wat structureel onwerkbaar blijft, is de tussenvorm.

Drie. Ruimte voor de dialoog. De vragen uit 6.4 worden beantwoord met de competentiecentra, in een traject dat start met het gesprek over wat een competentiecentrum is en wie erbij hoort. De instrumenten daarvoor liggen klaar en worden in een afzonderlijke nota voorgelegd, samen met wat zij aan capaciteit vragen.

Wat het huis zich daarmee verbindt te doen, staat gebundeld in bijlage 2: elf zinnen die samen de tweepager voor het directiecomité vormen.

Wat

De finaliteit en de definitie van een competentiecentrum

De verhouding tussen de verticale en de horizontale as: adviseren of sturen

Lidmaatschap, samenstelling en afbakening per centrum

Wie beslist

Deze nota

Het directiecomité

De dialoog met de competentiecentra

De uitdagingen rond competentiecentra worden vaak beschreven in termen van communicatie, betrokkenheid of engagement. Deze nota leest ze als ontwerpopgave. Dat is een geruststellende lezing: ontwerpproblemen zijn oplosbaar, mits ze expliciet worden gemaakt — en mits iemand de keuze maakt.

Bijlage 1: het denkteam achter deze nota

Deze nota vertrekt vanuit een expliciete ontwerplogica. De vraag hoe competentiecentra kunnen bijdragen aan kwaliteit, expertise en organisatieontwikkeling laat zich niet vanuit één discipline beantwoorden. Deze nota vertrekt daarom vanuit negen complementaire perspectieven. Elk van hen helpt een andere ontwerp vraag beantwoorden. Samen vormen zij geen model, maar een taal om ontwerpkeuzes bespreekbaar te maken

Matrix & competentiecentra: het ontwerp kader

Negen ontwerp vragen, negen antwoorden

 Structuur Waarom een matrix nodig is <i>Complexe vragen vragen structuren.</i> Jay Galbraith	 Afdruk Waarom horizontale ambitie strandt <i>Zoals wij overleggen, zo bouwen wij.</i> Melvin E. Conway	 Spanning Waarom spanning onvermijdelijk is <i>Excelleren in vandaag én morgen.</i> James G. March
 Regels Waarom regels noodzakelijk zijn <i>Gedeelde middelen, heldere regels.</i> Elinor Ostrom	 Mandaat Waarom mandaat prestatie bepaalt <i>Verantwoordelijkheid én ruimte.</i> J. Richard Hackman	 Praktijk Waarom praktijk telt naast structuur <i>Wat mag hier gevraagd worden?</i> Étienne Wenger
 Deel én geheel Waarom lidmaatschap gelaagd is <i>Elk deel is ook een geheel.</i> Arthur Koestler	 Bestaansreden Waarom we onszelf moeten bevragen <i>Middelen komen en gaan.</i> Steen Wackerhausen	 Twee lussen Waarom leren twee lussen kent <i>De uitvoering én het uitgangspunt.</i> Chris Argyris & Donald Schön

Visienota competentiecentra - UPC KU Leuven - 2026

Jay Galbraith: welke structuur past bij onze opdracht?

Galbraith vertrekt van een eenvoudige gedachte: organisaties moeten zo gebouwd worden dat zij de complexiteit van hun opdracht kunnen dragen. Wanneer kwaliteit, expertiseontwikkeling en operationele continuïteit tegelijk belangrijk zijn, ontstaat vanzelf meer dan één legitieme organisatieloga.

Zijn bijdrage aan deze nota: de matrix is geen modetrend, maar een antwoord op een complexe opdracht.

Melvin E. Conway: waarom blijft ontwerp soms theorie?

Conway observeerde dat organisaties systemen bouwen die lijken op hun eigen communicatiestructuur. Ambities die niet zichtbaar worden in overleg, mandaat en besluitvorming, bereiken de praktijk niet.

Zijn bijdrage aan deze nota: een horizontale ambitie vraagt een horizontale structuur.

James G. March: waarom hoort spanning erbij?

March beschrijft de spanning tussen wat vandaag werkt en wat morgen nodig is. Organisaties moeten tegelijk uitvoeren en vernieuwen.

Zijn bijdrage aan deze nota: de spanning tussen diensten en competentiecentra is geen fout in het systeem, maar een gevolg van het systeem.

Elinor Ostrom: hoe beheren we gedeelde middelen?

Tijd, aandacht en expertise zijn gedeelde middelen. Meerdere partijen hebben er een legitieme claim op. Haar bijdrage aan deze nota: zonder expliciete spelregels verschuift de spanning naar individuen. Governance beschermt samenwerking.

J. Richard Hackman: wanneer ontstaat duurzaam engagement?

Mensen kunnen pas duurzaam verantwoordelijkheid opnemen wanneer hun verantwoordelijkheid en hun beslissingsruimte met elkaar in evenwicht zijn.

Zijn bijdrage aan deze nota: resultaatverantwoordelijkheid zonder mandaat blijft afhankelijk van goodwill.

Étienne Wenger: waaraan herken je een levende kennisgemeenschap?

Wenger kijkt niet in de eerste plaats naar structuur, maar naar wat er tussen mensen gebeurt: welke vragen gesteld worden, welke ervaringen circuleren en welke kennis wordt gedeeld.

Zijn bijdrage aan deze nota: een competentiecentrum legitimeert zich via zijn praktijken.

Arthur Koestler: wie 'draagt' de opdracht?

Mensen behoren tegelijk tot verschillende gehelen: een dienst, een discipline, een competentiecentrum en het ziekenhuis als geheel.

Zijn bijdrage aan deze nota: lidmaatschap vraagt een vorm die lokale verankering én organisatiebrede verantwoordelijkheid tegelijk mogelijk maakt.

Steen Wackerhausen: waarom ontstaan professionele grenzen?

Professionals ontwikkelen manieren van kijken, denken en handelen die zo vanzelfsprekend worden dat zij uit beeld verdwijnen.

Zijn bijdrage aan deze nota: een competentiecentrum bewaakt niet alleen kennis, maar organiseert ook de ruimte om die kennis kritisch te onderzoeken

Chris Argyris en Donald Schön: Hoe voorkomt een organisatie dat zij haar eigen vanzelfsprekendheden bevestigt?

Organisaties verbeteren voortdurend hun uitvoering. Veel moeilijker is het om de uitgangspunten achter die uitvoering opnieuw ter discussie te stellen.

Hun bijdrage aan deze nota: een competentiecentrum leert niet alleen beter werken, maar onderzoekt ook periodiek of het nog aan de juiste opdracht werkt.

Bijlage 2. Wat het huis zich verbindt te doen

Elk deel van deze nota eindigt met *Wat hieruit volgt*. Samen vormen die elf zinnen wat dit huis zich met deze nota verbindt te doen.

1. Het ziekenhuis hanteert vanaf nu één definitie van een competentiecentrum en belegt de bemanningsopdracht uitdrukkelijk elders.
2. Het ziekenhuis organiseert en beschermt ruimte waarin professionele perspectieven elkaar ontmoeten, bevragen en verrijken. Georganiseerde vreemdheid is een expliciete opdracht.
3. Gemengde samenstelling, externe stemmen en een andere context krijgen een vaste plaats in de agenda van elk competentiecentrum.
4. De organisatie kiest expliciet hoe de verticale en de horizontale as zich tot elkaar verhouden, afhankelijk van de opgave, het risicoprofiel en het gewenste resultaat.
5. Ontwerpkeuzes worden eerst verantwoord vanuit de spanning die zij helpen dragen, en pas daarna vanuit de structuur die zij creëren.
6. Het ziekenhuis kiest samen met de competentiecentra één taalregister voor lidmaatschap, en houdt dat consequent aan.
7. Elk centrum situeert zichzelf op de vier dimensies en spiegelt dat beeld aan diensthoofden, directie en collega-centra.
8. Elk competentiecentrum beschikt over de zeven kerncomponenten; de drie ontwerpprincipes bepalen hoe die worden ingevuld.
9. Ambitieniveaus worden in dialoog vastgelegd tussen coördinator, diensten en directie, en periodiek herbevestigd.
10. Bij de beoordeling van een competentiecentrum weegt de aanwezigheid van praktijken even zwaar als de aanwezigheid van structuur.
11. Het huis organiseert drie toetsen op drie niveaus, en herijkt op basis daarvan zowel het ontwerp als deze nota.

Bronnen

- Argyris, C., & Schön, D. (1978). *Organizational Learning*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Conway, M. E. (1968). "How Do Committees Invent?" *Datamation*, 14(4), 28-31.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). "The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior." *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Edmondson, A. (1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams." *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.
- Galbraith, J. R. (1973). *Designing Complex Organizations*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hackman, J. R. (2002). *Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kniberg, H. (2012). *Scaling Agile @ Spotify*.
- Koestler, A. (1967). *The Ghost in the Machine*. London: Hutchinson.

- Lee, J. (2020). *Failed #SquadGoals*.
- March, J. G. (1991). "Exploration and Exploitation in Organizational Learning." *Organization Science*, 2(1), 71-87.
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). "Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future." *Academy of Management Perspectives*, 27(4), 324-338.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wackerhausen, S. (2009). "Collaboration, Professional Identity and Reflection Across Boundaries." *Journal of Interprofessional Care*, 23(5), 455-473.
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Verantwoording

De begrippen *eerste- en tweede-orde-reflectie*, het *immuunsysteem van beroepsgroepen*, het beeld van *Maren* en het onderscheid tussen *middelen en bestaansredenen* zijn ontleend aan het werk van Wackerhausen. De vertaling van deze concepten naar de context van competentiecentra en ziekenhuisorganisatie is een eigen uitwerking van de auteur.